

ICUの対立を課題・プロセス・関係の3層で読み解く — 「困った家族」の多くはプロセス不全の帰結 (ナラティブレビュー・CritCare2026)

出典 Jabaley CS, Brummell Z, Benoit DD, Kentish-Barnes N, Metaxa V. Conflict in intensive care units: a conceptual framework for patient, family, team, and inter-service disagreement. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06248-7

掲載誌 Critical Care (2026-08-15)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06248-7 (本文PDFは別途)

原題 Conflict in Intensive Care Units: A Conceptual Framework for Patient, Family, Team, and Inter-Service Disagreement



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① **面談前のチーム擦り合わせ(pre-conference team alignment)を「面談の一部」として明文化する** 本レビューが最も強く推している低コスト介入がこれ。家族に会う前にチーム内の不一致を先に表に出しておく。理由は明確で、チーム内の未解決の不一致は、家族には「言うことが人によって違う」というかたちで届くから。当院のICでも、指導医・専攻医・看護師・リハ・薬剤師で見立てがずれたまま面談に入ると、家族側には「プロセスの不公平」として蓄積する。所要3分でよい。ただし本論文は「単独での実証評価は存在しない(低い確実性・間接的エビデンスのみ)」と正直に書いており、その前提で導入する。

② **「困った家族」というラベルをカルテから外す** 本論文の中核メッセージ。difficult は人ではなく「相互作用」を指す語であり、実証的にも医療者側・システム側の要因(燃え尽き・職務不満足)と相関する。米国コホートでは黒人患者にネガティブな記述語が約2.5倍の頻度で付く。当院では、記録は「行動と文脈の記述」に統一する運用にできる(例:「非協力的」ではなく「同日3回説明を求められ、担当医が3人替わっていた」)。

③ **ICU入室・退室・転院の「決定権の所在」を文書化する** 診療科間対立(特に外科医と集中治療医)の本質は課題対立ではなくプロセス対立、つまり「誰が決めるか」の境界紛争だと本論文は整理する。米国調査では62%の外科医が「手術に進むことは術後生命維持を受け入れる暗黙の契約」を支持した。当院の術後患者・救急からの入室・SDU/HDU転出の各局面で、誰が最終決定するか・意見が割れたときの解決経路(誰にエスカレーションするか)を1枚に。院内3分の1超の病院にこの種の方針がないと本論文は指摘している。

④ **緩和ケアは「トリガー基準」で前もって呼ぶ** 揉めてから呼ぶと、集中治療チームには「お前の診療は不十分だ」という同一性への脅威(identity threat)になる。ICU入室のおよそ7人に1人がトリガー基準を満たす。一方で「高リスク家族全員に専門家主導の予後説明面談」という網羅型は家族の苦痛を減らさず、ある試験ではむしろ増やした。当院でも一次緩和ケア(ICUチーム自身が行う症状管理とgoals-of-care)と専門緩和ケアを分けたうえで、後者はトリガー起動型にする。

⑤ **看護師を家族面談の「席」に構造で入れる** 小児ICUでは98%の看護師が「面談に出るべき」と答えたが、招かれた者のうち継続的に出席できたのは17%。成人多施設では45%が「ほとんど／全く参加しない」。ただし恵まれた学術施設では時間圧(10～19%)より「医師が意見を求めない(60%)」「訓練不足(66%)」が上回った。当院は Hotel ICU の多職種カンファがすでにある。次の一手は「面談スケジュールに担当看護師の代替要員を先に確保する」という業務設計側の手当て。

⑥ **倫理風土(ethical climate)を測って改善対象にする** DISPROPRICUS(68 ICU)で、風土「良好」クラスターのICUは過剰治療の同定が早く、治療制限の決定にも早く到達した。風土は離職意向とも結びつく。看護師1人あたりの離職コストは米国推計で7.5万ドル。当院の経営戦略会議に出す資料として、倫理風土と離職の連関は「投資の根拠」になる。ただし CODE 試験は「医師コーチングだけでは風土は動かない」と示しており、チーム単位の介入が要る。

⑦ **意識のある患者本人の声を制度化する** 浅い鎮静の推進で「意思決定に参加できるICU患者」は増えている(政策文書では少なくとも4分の1)。ところが本人が代理者やチームと意見を違えると、その不一致が「判断能力の問題」に読み替えられやすい。当院の鎮静プロトコルが浅鎮静寄りである以上、これは近い将来の実務課題。ICでは「本人が話せるなら本人に先に聞く」を明文化しておく。

⑧ **変わらないこと** 本論文はナラティブレビューであり新しい治療推奨はない。コミュニケーション介入は近位アウトカム(理解・満足・会話の質)を改善するが、遺族の長期の不安・抑うつ・PTSD・遷延性悲嘆はおおむね改善しない。当院で家族支援を「遺族の心理予防」として売り込むのは筋が悪い。近位アウトカムとスタッフ側の効果(燃え尽き・離職)で正当化する。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: ICUの対立は普遍的。CONFLICUS研究(24か国323 ICU)では71.6%のスタッフが直前1週間に対立を経験。看護師と医師の組が最多。家族との対立、終末期の治療制限をめぐる対立、道徳的苦悩、燃え尽きの関連も個別には繰り返し報告されてきた。
- **Unknown**: 「対立」に単一の合意された定義がなく、検出方法も研究ごとにばらばら。チーム内・チーム間の対立は、道徳的苦悩・心理的安全性・倫理風土・協働・不適切医療の知覚・沈黙と発言、といった隣接構成概念に散らばっており、「conflict」を主要索引語にしていない。そのため「チーム内対立は研究が乏しい」という誤った印象が生まれている。介入研究も、対立の解消そのものを主要アウトカムに置いたものがほとんどない。
- **What's new**: 組織心理学の課題・プロセス・関係の3分類を輸入し、(a) 家族との対立と (b) チーム内・チーム間の対立という2つのアリーナを、同じ増悪経路として1枚に統合した。中心的主張は2つ。第一に、臨床家が「困った家族」と呼ぶものの多くは、先行するプロセス不全への反応であって純粋な対人問題ではない。第二に、家族対立とチーム対立は連結しており、未解決のチーム不一致は「矛盾した推奨・食い違うメッセージ」として家族に届く。さらに、判断能力を保つ患者本人が対立の当事者として見落とされてきたことを指摘し、介入を「対立の型(課題・プロセス・関係)×段階(発生期・確立期・膠着期)」の2軸で整理したエビデンス表(Table 5・Table 6)を提示した。



全体要約

要旨

ひとことで ICUの対立は「何をすべきか(課題)」から「誰がどう決めたか(プロセス)」を経て「信頼と敬意が壊れたか(関係)」へ移動する。関係領域に落ちると解決は格段に難しくなるため、投資すべきは個人のコミュニケーション技術ではなく、回診・役割の明確化・面談前のチーム擦り合わせ・倫理風土といった構造の設計である。

- ICUの対立は「稀な事故」ではなく、不確実性・高い倫理的賭け金・分散した権限・時間と資源の制約という構造から必然的に生じる。資源が潤沢な施設でも消えない。
- 著者らは対立を「目標・価値・利害の、知覚された、または実際の非両立性であって、負の感情や自分の目的が妨げられている感覚を伴うもの」と定義する。単なる意見の相違 (disagreement) とは区別する。相違は判断や選好の差でよく、負の感情も目標阻害も伴わなくてよい。
- 課題対立 (task) = 何をすべきか。プロセス対立 (process) = 誰がどう決めるか。関係対立 (relationship) = 信頼・敬意・同僚性が損なわれたか。3者は混ざり合い、混ざるほど害が強まる。
- 増悪には増幅因子 (予後の不確実性・感情の強度・発言の制約・階層) と、先行条件 (過去の否定的な医療体験・文化的言語的一致の乏しさ・既存の苦痛) がある。先行条件はそれ自体では対立ではないが閾値を下げる。
- 家族側：意思決定代理は制度が作った役割であり、構造的に非対称。知識・専門的枠組み・(法域によっては) 権限を欠いたまま重い決定に巻き込まれる。前向き研究では19%の代理者がICU医療をほとんど理解しておらず、ほぼ半数が患者のケア内容の知識に乏しかった。
- チーム側：看護師と医師の境界が最も記録された対立型かつICUで最多。ETHICUS-2 (36か国) では終末期決定における医師と看護師の一致率が約40%から100%までばらついた。症状コントロールを医師だけで決めたとき、医療が不適切だと知覚されるオッズは73%高い。
- 診療科間：外科医と集中治療医の争いは、しばしば「術後の権限は誰にあるか」というプロセス紛争。両者の主張はどちらも擁護可能で、アウトカムデータはどちらにも軍配を上げない。
- 介入は型と段階に合わせる。予防・設計 (構造化回診、役割の明確化、面談前擦り合わせ、標準化された既定経路と時間制限つき治療トライアル、倫理風土) → 早期の認識と現場での鎮静化 → 膠着したときの公式支援 (価値の対立には倫理コンサルト、関係の断裂には調停)。
- コミュニケーション介入は近位アウトカム (理解・満足・会話の質) を確実に改善するが、遺族の長期心理アウトカムはおおむね改善しない。むしろ「弔意の手紙」のランダム化介入は6か月後の抑うつとPTSD症状を増やした。例外は「死のプロセスそのもの」を支える介入 (積極的な終末期面談+遺族向け冊子、3ステップ戦略、蘇生時の家族立ち会い、ICUダイアリー)。
- 結論：「集中治療における意見の相違は不可避だが、破壊的な対立は不可避ではない」。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む この論文は臨床試験ではなく、ICUの「もめごと」を組織心理学の道具で整理し直した総説である。用語を先に押さえておくと読みやすい。

対立(conflict)と意見の相違(disagreement)：本論文の定義では、対立は「目標・価値・利害の非両立性が知覚され、負の感情または目的の阻害感を伴うもの」。相違はそれ自体では負の感情も阻害も伴わない。対立は個人の内側ではなく当事者の「あいだ」に生じ、したがって本質的に主観的である。非両立性は「知覚されれば足りる」ので、片方だけが先に感じている段階がありうるし、外からは見えないことがある。

課題・プロセス・関係(task-process-relationship)：組織心理学 Jehn(1995)と de Wit・Greer・Jehn(2012)に由来する3分類。ICUに固有の検証はされていないが、職場チーム研究で十分に支持され、医療チーム対立の統合レビューにも適用されている。著者らは「固定した順序」ではなく「整理のための発見的枠組み」だと明言している。

建設的な意見の相違(productive disagreement)：本論文の定義では、(1) 臨床課題に焦点が当たっており、(2) 当事者が公正と受け入れるプロセスの中で起き、(3) 関係に恒久的な損傷を残さないものの。

代理決定者(surrogate)：患者の判断能力が失われたとき、患者に代わって(あるいは患者の意向を解釈して)決定に関与する人。米国・カナダ・オーストラリアでは制定法や判例法による代理者の優先順位が定まっており、事前の法的文書がなくても家族が既定の決定者になる。英国など多くの法域は「最善の利益(best interests)」や「利益基盤(benefits-based)」モデルで、患者が持続的代理権(Lasting Power of Attorney)や有効な事前決定、裁判所選任の代理人を用意していない限り、近しい人に相談したうえで臨床医が決定する。

道徳的苦悩(moral distress)：正しいと信じる行動が制約されて取れないときの情動的負荷。Epstein と Hamric は、未解決の倫理的懸念が「道徳的残渣(moral residue)」を残し、次のエピソードの閾値を下げていく「クレッシェンド効果」を記述した。

心理的安全性(psychological safety)：対人的リスクを取っても罰せられないというチームの共有された認識(Edmondson 1999)。ICUでは、指導医の包摂的な振る舞い(inclusiveness)が最大の規定因子。

倫理風土(ethical decision-making climate)：倫理的意思決定の質についての共有された認識。相互の敬意、開かれた学際的省察、信頼など。自己評価ツールが検証されている。

NURSE：感情に応答するコミュニケーション枠組み。Name(名づける)・Understand(理解を示す)・Respect(敬意を示す)・Support(支持する)・Explore(探索する)。

時間制限つき治療トライアル(time-limited trial, TLT): 集中治療を「期限つき」で行い、あらかじめ決めた時点・基準で再評価すると合意する方法。二者択一の対立を、逐次的な決定の連なりに変換する。

APP(advanced practice provider): ナースプラクティショナーとフィジシャンアシスタント。米国成人ICUの約72%に配置され、研修医のいる施設(約52%)より多い。

手続き的公正(procedural justice): 結果に不満でも、過程が公正・透明・敬意あるものであれば人は決定に納得しやすい、という知見。

2. 背景と目的

対立はICU業務の予測可能な一部である。不確実性、高い賭け金、分散した権限、時間と資源の制約が組み合わさるためであり、著者らは「資源不足の問題ではない」と明確に否定する。資源の潤沢な施設でも対立は残る。駆動因が構造的だからである。

規模の目安:

- **CONFLICUS研究**: 24か国・323 ICU。直前1週間に対立があったと報告したスタッフは **71.6%**。
- **スコーピングレビュー**: 成人ICU 15研究。対立源は「ケア環境(人員不足・資源制約・面会制限)」「終末期ケア」「マネジメント」に集まる。

しかしこの高い頻度にもかかわらず、分野には合意された対立の定義がない。研究デザインも検出方法も大きくばらつく。対立はしばしば「隣接するラベル」の下で検討され、それ自体としては扱われない。とりわけ、チーム内・チーム間の対立の文献は、家族との対立の文献よりも散逸している。

本レビューが扱うアリーナは2つ:

- ① 臨床チーム 対 患者・家族・代理決定者
- ② 臨床チーム内、および臨床チーム間

著者らは「構造的レンズ」を採り、「病理のレンズ」を採らない。この区別は倫理的に重要である。構造的レンズは責を割り当てない。対立の当事者であることは関係の中の位置の問題であって、必ずしもその歴史に対する有責性ではない。たとえば過去の医療体験から持ち越された不信は、対立の閾値を下げる先行条件ではあるが、いま初めて会った臨床医との対立そのものではない。臨床医が当事者になるのは、現在の関係の中で非両立性が知覚されたときである。

ただし構造的レンズは「将来に向けた責任(prospective responsibility)」は割り当てる。増悪を防ぎ修復を追う責任である。この責任は、各当事者の役割・パワー・行動能力に比例して分配されるべきで、ひとりの「困った人」に所有させるものではない。

同時に著者らは慎重な留保を置く。将来責任は解決を保証しない。熟練した努力(ファシリテーション・仲裁を含む)を尽くしてもなお解決しない対立は存在する。**対立に巻き込まれることも、対立が続くことも、個人的・専門職的な失敗ではない。**

多くの医療文化では、意見の相違は「複雑な決定の正常で時に有用な一部」ではなく「避けるべきもの」として扱われている。ここに本レビューの狙いがある。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー。系統的レビューではない。目的が解釈的であるため、と明示されている。すなわち、道徳的苦悩、心理的安全性、倫理風土、交渉学、組織対立という複数の別個の文献群を、単一の問いに対するメタアナリシスに還元するのではなく、共有された枠組みへ統合することを狙う。
- **検索源(学際的であるため意図的に医学外を含む)**:
 - PubMed/MEDLINE
 - PsycINFO と Business Source Complete(組織心理学・経営学をカバー)
 - HeinOnline(法学をカバー)
 - Google Scholar
- **検索期間**: 2026年3月31日まで。引用追跡と主要文献リストのハンドサーチを追加。査読期間中、査読者コメントに対応するため同一の情報源に対して2026年7月までの追加の対象検索を実施した。
- **選択方針**: 一次研究と権威ある統合を優先。最も論拠を支える定量的主張については原典に当たって確認した。
- **エビデンスの強さの表記**: 要約表(Table 6)の "Strength of Evidence" は、研究デザインと直接性についての著者らの質的判断であり、形式化された・プロトコル化された格付けではない。
- **著者らが自ら置く認識論的留保**: 解釈的統合であるため、本レビューは間主観的(intersubjective)であり、比較可能な測定値の集計に還元できない。
- **除外範囲**: 家族内部の対立(intra-family conflict)は重要だが本稿の範囲外として深く扱わない。
- **報告ガイドライン関連**: ナラティブレビューの方法論と質評価(SANRA尺度など)を参照文献として挙げている。

4. 課題・プロセス・関係の枠組み

この枠組みは「対立がどう増悪するか診断地図」である(Table 1、Figure 1)。集中治療に固有の検証はされていないが、組織心理学の職場チーム研究に十分支持され、医療チーム対立の統合レビューに適用されている。

る。著者らはこれを「整理のための発見的枠組み」と位置づけ、その価値は (a) 分断された文献群を統合すること、(b) 検証可能な予測を生むこと、にあるとする。生成される予測は3つ。

- 1 対立は課題領域・プロセス領域から関係領域へ移動する傾向がある
- 2 プロセス不全は、課題対立や関係対立として現れるものの、頻度が高く見落とされがちな駆動因である
- 3 構造的介入と対人的介入は、同一の因果経路の異なる点に作用する

Table 1. 対立の3類型による分析枠組み

型	中心的な問い	集中治療での例
課題対立(task)	何をすべきか	予後と経過の評価／治療の適切性と強度／体外循環補助の適応／蘇生に関する選好／抗菌薬の拡大・縮小
プロセス対立(process)	誰が、どのように決めるか	役割上の権限と決定の所有権／コンサルト・紹介の規範／家族面談の構造と日程／入室・退室・トリアージのガバナンス／代理者の特定と決定負担(注)
関係対立(relationship)	信頼と敬意に何が起きたか	専門職間の敵意と個人攻撃／家族のチームへの不信／診療科間の対抗心と縄張り行動／同一性への脅威と道徳的損傷／「あの人は患者のことを考えていない」

注：正式な代理決定が既定でない法域（英国などの最善の利益・利益基盤モデル）では、対応するプロセスの問いは「家族と臨床医がその判断にどのように共同で関与するか」になる。原表は Jehn(1995)および de Wit・Greer・Jehn(2012)を改変。多くのICU対立は課題またはプロセス領域で始まり、関係領域へ移動したときに破壊的になる、という含意が付されている。

3類型が混ざるとき

これらの型はしばしば結合し、結合すると害が強まる。**関係対立は最も解決が難しい**。なぜなら当事者は、以降のあらゆる相互作用を不信というレンズを通して読むようになるからである。

その情動レジスターは不信だけではない。怒り・恐れ・悲嘆に広がり、それぞれが固有の道徳的重みを持つ。怒りは「知覚された不正を告げる道徳感情」と記述されてきたが、関係の中では不信からきれいに切り離せることは稀で、過去の害に対する自己防衛的反応として持続しうる。

関係的同一性の理論(relational identity theory)は、その人の専門職的役割や道徳的統合性への脅威が高強度の関係対立として機能しうると論じており、このパターンはICU研究でも観察されている。**同一性への脅**

威として体験された対立は、通常の課題不一致とは挙動が違う。すなわち、より速く増悪し、エピソードをまたいで蓄積する道徳的残渣を残し、燃え尽きと離職意向に寄与する。

したがって緩和策は、実質的な問いに戻る前に、脅かされた立場をまず承認しなければならない。争点が「何をすべきか」から「異論を唱えた自分は尊重されているのか」へ移ってしまっているからである。

増幅因子と先行条件

増悪を増幅する因子：予後の不確実性、感情の強度、発言の制約 (constrained voice)、階層。

先行条件(それ自体は対立ではないが脆弱性を高める)：過去の否定的な医療体験、文化的・言語的一致の乏しさ、既存の苦痛。

この種の不信は、ICUの代理者において測定可能であり、新しい関係へ持ち込まれる。患者本人の、あるいは家族の否定的な医療体験は、それに一切関与していない医師への信頼の低下と関連する。

2つの層は時間的にも分離できる。

- **パイロットICUコホート：**代理者の医療システム不信は在室中に低下したが、担当医への信頼は独立に動いた。
- **多施設ICUコホート：**代理者の担当医への信頼は、共同意思決定の行動と関連して上昇した。知覚された振る舞いが重要であることを示す。

発言しないこと(failing to speak up) は一般的で、コミュニケーション不全に寄与する。階層は「誰が最初に対立を知覚するか」も規定する。医師は看護師よりも一貫して協働を良好に評価する。これは欧州でも米国でも、ICUでもそれ以外でも同じである。したがって **医師は他者が経験している対立を過小評価している可能性が高く、認識されない対立は対処されえない**。確実に検出するには、チーム全員からの構造化された入力が必要になる。

公平性(equity)の位置づけ

著者らは公平性を「別の対立カテゴリー」としては扱わず、3領域すべてに影響するものとして扱う。社会的階層は、誰の語りが信用に足ると扱われるか、誰が理解可能な情報を受け取るか、誰が決定に参加するか、誰の苦痛が「脅威」と読まれるかを規定する。ただし局所的に顕著な軸は設定によって異なり、人種、民族、先住性、カースト、階級、宗教、移民ステータス、言語などが挙げられている。さらに医療体験は、身体的・知的障害、性的指向、住居状況といったこれら以外の次元でも異なる。

重要な但し書き：これらの属性自体が対立を引き起こすのではない。不公平は、制度と相互作用がそれらの属性を「発言・信頼・情報・強制的対応への曝露の差」に変換したときに生じる。機序レベルのエビデンスの多くは米国の黒人患者に関する研究に由来する、と著者らは断っている。

5. 補完的なレンズ

枠組みを補う4つの視点。

交渉学(negotiation science): 利害(interests、当事者が抱く根底の必要と価値)と、立場(positions、表明された具体的要求)を区別する。たとえば「すべてをやってほしい」という要求は立場であり、その下には「患者が見捨てられないと知りたい」という利害があるかもしれない。**立場が衝突していても利害は両立する**。ただし原則立脚型交渉(principled negotiation)は、実在するあるいは知覚されるパワーの非対称を軽視しているという批判を受けている。臨床では、臨床医が役割と専門性の双方から権威を持つため、この批判は効いてくる。

手続き的公正(procedural justice): 過程が公正・透明・敬意あるものであれば、結果に同意しなくても人は決定により満足する。

心理的安全性と関係的協調(relational coordination): チームが不一致を提起し処理できる条件を特定する。共有された目標と知識、相互の敬意、頻繁な問題解決型コミュニケーション。

基本的必要・中核価値 対 表層の規範・期待: 実証的基盤は弱いが実務的に有用なレンズとして、著者らは「基本的な人間の必要と中核価値(集中治療で競合する利害、個人としての患者への敬意)」と「規範と期待というより表層の層」を分ける。「価値観の対立」とラベルされるものの多くは、実は表層での衝突であり、解決とは当事者を深い層に戻すことを意味する。

この区別は倫理原則も曖昧にしうる。臨床医は、自ら非有益と判断する治療を続けることがあり、その最も多く挙げられる理由は家族の強い要求だが、臨床医自身のためらいも寄与する。このレンズで解釈すると、そこでは**善行(beneficence)**が「**家族を失望させないこと**」に読み替えられている。表層の関係が、より深い義務よりも優先されているのである。家族の側も、自律を「求めた治療を何でも受ける権利」として扱うことがある。

原則はより精密である、と著者らは書く。

- **自律**: 自分自身のケアについて、情報を得たうえで自発的に選ぶ権利(拒否を含む)。臨床医に対して、有害であるか目的を達成しえない治療の提供を義務づける権利ではない。
- **善行と無危害**: 自律の尊重によって置き換えられることのない、別個の義務として残る。

6. 構造化された課題不一致の価値

課題不一致には診断・予後・治療をめぐる相違が含まれ、原理的には、異なる知識と経験を持ち込むことで難しい決定を改善しうる。しかし **実証的支持は一般に思われているより弱い**。

メタアナリシスは、課題不一致とチームパフォーマンスの間に全体としては弱い関連しか見出していない。利益が集中するのは特定の条件下である:

- 1 課題不一致が関係対立と弱くしか結合していないとき
- 2 チームが組織階層の上位に位置するとき
- 3 測定されるアウトカムが、チームの広い効率や産出ではなく、その特定の決定の質であるとき

したがって **課題不一致の生産的な可能性は、前提として仮定するのではなく、意図的に作り出さなければならない。**

構造化された異論(structured dissent)は、高リスクのチーム決定で知られたリスクである「早すぎる合意(premature consensus)」を防ぐ。最も近い臨床エビデンスは診断推論から来る。最初に思いついたもっともらしい答えに落ち着くのではなく代替案を検討するよう医師に促すと、バイアスの生じやすい症例で正確性が改善した。

チームレベルで最も強いアウトカムシグナルはチーム訓練バンドルから来る。

- ICUのクルー・リソース・マネジメント(CRM)コホート: 重篤な合併症の減少と死亡率の低下を報告
- 大規模な医療チーム訓練プログラム: 外科死亡率の低下と関連

ただし著者らは即座に留保を置く。これらはバンドル介入であるため、構造化された不一致に固有の寄与は分離できない。またICUでの結果は全体としては一貫しない。臨床医の行動にも患者アウトカムにも効果を認めなかった多施設対照試験がある。

不一致が voiced されるかどうかと同じくらい、どう扱われるかが重要である。実務的教訓は「不一致を単に容認するのではなく、構造化すること。具体的には、異論を求める回診、指名された devil's advocate (悪魔の代弁者) 役、そして「アイデアへの挑戦」と「人への挑戦」を分けるチーム文化。

正式な devil's advocacy は対照研究で決定の質を改善するが、そのエビデンスは大部分が非臨床である。したがって著者らはその臨床的価値を「実証されたもの」ではなく「機序的に動機づけられたもの」と見るのが最善だとしている。

7. 患者・家族・代理決定者との対立

家族と代理者はほぼすべてのICUベッドサイドにいる。彼らは患者の価値観・選好・微細な変化についての知識を持ち込み、チームの理解を深める。共感的に関わればその参加は共同意思決定を強める。対立が生じるのは、課題レベルの誤解やプロセスレベルの隙間が放置されたときであり、コミュニケーションと信頼への早期の注意が増悪を防ぎうる。

このアリーナは不均質である。著者らは「誰が対立しているか」×「何をめぐってか」の2軸分類(Table 2)で分布を整理する。またこの領域の駆動因には既に「鑑別診断」が提案されており、寄与因子は家族・臨床医・制度にまたがる。家族だけに宿るのではない。

チーム-家族対立は通常最大のカテゴリーで、その内訳は「コミュニケーション不良」と「生命維持治療をめぐる不一致」にほぼ半々に分かれる。つまりおよそ半分は、価値観の衝突ではなくプロセスの問題として現れている。

有病割合は「誰に聞くか」にも依存する。医師は代理者や看護師よりはるかに低頻度でしか対立を報告しない。したがって単一情報源による数値は過小評価である。

Table 2. 重症患者をめぐる対立の2軸分類

当事者	課題(task)	プロセス(process)	関係(relationship)
チーム-家族:57% (Studdert)／17% (CONFLICUS)	生命維持治療の選好の衝突 44% (Studdert); 医師と代理者の予後の不一致 53% (White)	コミュニケーション不良 44% (予後理解の困難 19%、言語の障壁 13%); 決定者が不在または不能 15～16%; 家族のおよそ半数が理解不良	対処・情動反応 15%; 家族の臨床医への不信 3%; 宗教的・文化的 6%
チーム内:31% (Studdert); 看護師-医師の組が最多 (33%・CONFLICUS)	ケアまたは管理方針の不一致 55% (疼痛・鎮静 9%、予後 5%); 生命維持治療 7%	コミュニケーション不良 16%; リーダーシップの欠如 9%; 調整の欠如 7%; 看護師が決定から排除 9%	拡散的。医師間の摩擦と燃え尽き
チーム-患者:17% (CONFLICUS)	判断能力のある患者が推奨を拒む: 研究が乏しい	患者が迂回される・代弁される; 拒否が判断能力の問題に読み替えられる	患者が聞かれていないと感じる: エビデンスの空白
家族内:12% (Studdert)	生命維持治療 57%; その他のケア計画上の決定 37%	コミュニケーションの問題 13%; 代理者・代弁者の指名 10%	内部の敵意 3%

原表の脚注(重要):

- **全体の有病割合**: 24か国323 ICUで、ICUスタッフの71.6%が直前1週間に1件以上の知覚された対立を報告。
- **単一情報源では系統的に過小検出される**: 医師は27.8%の症例で対立を同定したのに対し、代理者は42.3%。看護師は医師より高頻度に同定した。
- **受動的な代理決定役割は不安(88%)・抑うつ(50%)と関連する**。代理者の決定葛藤(decisional conflict)は一般的で、事前のアドバンス・ケア・プランニングによって減る。

- **数値の比較可能性に関する著者の警告**: 割合は分母の異なる2つのコホートに由来し、直接比較できない。Studdert らの数値は対立を相互排他的な当事者カテゴリーに分割したもので合計100%になる(チーム-家族57%、チーム内31%、家族内12%)。CONFLICUS の数値は「対立を報告した回答者のうち各当事者と対立を経験した者の割合」であり、1人が複数の当事者と対立を報告しうるため重複し、合計は100%にならない。
- 情報源のカテゴリーは原著の分類ラベルを反映しており、情動反応や不信は「対立そのもの」ではなく「対立への既存の脆弱性」を反映している可能性がある。

8. 家族の制度的立ち位置

代理決定は制度が構築した役割である。近年、家族は「面会者」から「能動的パートナー」へ、そして患者が意思疎通できないときは「代理決定者」へと再定義されてきた。その範囲と権限には大きな国際差がある。

この立場は構造的に非対称である。家族は、臨床医の知識基盤も、専門職としての枠組みも、(システムによっては)正式な権限も持たないまま、重大な決定の責任を引き受ける。

- **知識について**: 前向き研究では、19%の代理者がICU医療をほとんど理解しておらず、ほぼ半数が患者のケアについての知識に乏しかった。そして理解の程度そのものが、決定に参加する意思を左右していた。
- **枠組みについて**: 代理者はしばしば、確率、臓器系の推移、「適切性」の判断といった技術的言語を通じて状況に出会う。臨床医が翻訳に懸命に努めていてもそうなる。

著者らはここから重要な帰結を引き出す。これらの非対称は、個人の誤解というより「意思決定の組織のされ方の構造的特徴」と見るのが適切であり、**そのことが「集中的なコミュニケーション介入やファシリテーション介入が家族の心理アウトカムを確実に改善してこなかった」理由の説明を助ける。**

法域による違い

法域・モデル	誰が決めるか	補足
米国・カナダ・オーストラリア	制定法または判例法による代理者の優先順位。患者に判断能力がなければ、事前の法的文書がなくても家族が既定の決定者	「デフォルト代理者階層」型
英国ほか多数	最善の利益・利益基盤モデル等。患者に近い人に相談したうえで臨床医が患者に代わって決定する	例外は患者が Lasting Power of Attorney を指定、有効な事前決定を作成、または裁判所選任の代理人がいる場合
大陸欧州・イスラエル・アジア	この連続体上のさまざまな位置	ETHICUS-2 コホートは終末期決定への看護師関与に大きな国際差を記録
オーストラリア先住民コミュニティ	適切な代弁者はコミュニティが指名した長老や、核家族外の特定の親族でありうる	法的近親者を軸にした決定プロセスは、誰が語るべきかの同定自体を誤りうる
インド	医療上の意思決定における近親者の権威ある法的定義がない	各病院が独自の代理者階層を即席で作っている

著者らは「surrogate」を略称として使うが、これらの非対称は広く当てはまると強調する。家族が正式な決定者でない場所でも、家族は日常的に重大な決定に引き込まれ、患者の以前の意向の解釈を求められ、知識・権限・枠組みの同じ隙間に曝される。**法モデルが変えるのは「誰が正式な責任を負うか」であって、家族が対立を経験し寄与する役割ではない。**枠組みは法域中立に読むべきであり、個々の例は生成された文脈を反映しているにすぎない。

9. 枠組みを患者・家族との対立に当てはめる

課題領域

家族と代理者にとって課題対立は「何をすべきか」を中心に回る。予後、生活の質、治療の適切性についての評価の相違である。こうした不一致はしばしば価値観に基づくように見えるが、**予後の誤解は双方向に走る。**代理者は臨床医の推定を読み違えうるし、臨床医は家族が何を信じ何を優先しているかを読み違えうる。双方が相手についての誤った前提のうえで行動しうる。

文化的・宗教的コミットメント

生物医学的枠組みがうまく収容できない形で相互作用を形作る。宗教的信念は死が近いときの集中的治療の選好と関連しうるが、その関連は不均質である。奇跡を信じる代理者の中にも快適さ中心のケアを選ぶ人がい

る。

一見固定的に見える要求が、聞き出す価値のある宗教的・文化的コミットメントの上に立っていることがある。**249件の録音されたgoals-of-careの会話の多施設解析では、代理者は面談の16%で宗教的・霊的懸念を提起したが、臨床医は通常それを臨床的话题へ引き戻すか、探索せずに承認するにとどまった。霊的枠組みが扱われないと、家族は「見られていない」「切り捨てられた」と感じる。**

緩和には明示的なプロセスの足場が要る。構造化されたスピリチュアルケア、チャプレンやコミュニティのリーダーの関与、意思決定における役割の明確化。

終末期実践そのものの構造的な地域差

これらの文化的・宗教的パターンは個人レベルにとどまらない。

- **欧州ICU**: 死亡する患者のうち生命維持治療が能動的に中止される割合は、安定した北から南への勾配を示す。**北欧47%、中欧34%、南欧18%**。20年前に記録され、その後も再確認されている。
- **欧州外**: 東アジア、南アジア、中東、サハラ以南アフリカのICUでも同等の変異が記録されており、臨床的必要よりも法・宗教・家族の権威を追う。**インドのICUでは生命維持治療の能動的中止は終末期決定の7%にとどまり、西欧系列のおよそ45～80%と対照的。**
- **ラテンアメリカ**: ICU外の終末期ケアでも同様の地域的分岐が明らか。
- 患者の自律に対する態度は、個人の宗教性よりも地域と文化を追う。

結論として、多民族環境で文化的差異がチーム-家族対立として現れるとき、それは集中治療の構造的特徴と共同で産出されており、「その家族の文化」だけに位置づけることはできない。

プロセス領域

プロセス対立は明示的な課題不一致に先行して走ることが多い。正式な代理決定が規範でない場所でも、家族は判断能力を欠く患者の決定に引き込まれ、誰が決めるのか分からず、情報を一貫しない形で受け取り、プロセスに関わる急性の不安を感じる。

負担は現実である。**大多数の代理者はその役割から否定的な心理的影響を報告し、5人に1人は6か月時点で中等度から強度の後悔を抱く。**

そしてそれは、チームが自らの不一致を解決しないまま選択肢を提示したときに悪化する。Bruce らは、未解決のチーム不一致が goals-of-care の会話を形作りうる「パ・ド・ドウ(pas-de-deux)」を記述し、それが決定と臨床医の統合性の感覚の双方を傷めるとした。

「困った家族」というラベルの解剖

質的研究の蓄積は、臨床医が「家族の対立」と呼ぶものの多くを、3領域すべてにわたる制度的失敗への合理的な反応として再枠組みしている (Table 3)。

「difficult」というラベル自体も同じ精査に値する。

- それは長く「人ではなく出会い(encounter)」を記述する語と理解されてきており、通常は緊張した相互作用を示すシグナルである。
- 実証的にも、知覚された困難さは臨床医とシステムの要因を追い、**燃え尽きている、あるいは職務に不満足な臨床医ほど多く報告する。**
- ラベルは家族の特性と同じくらい「不当な扱いを受けたという知覚」を反映するので、義務は「困った当事者を管理すること」ではなく「その知覚に対処すること」である。
- 診療録に入力されたスティグマ的記述語は他の臨床医へ伝播し、彼らの態度とケアに悪影響を与える。患者や家族を difficult として描くことは、そうした言語の記録されたカテゴリーの1つである。
- **米国のコホートでは、こうしたラベルは不均等に適用され、黒人患者はネガティブな記述語のオッズが約2.5倍。**その駆動因は研究が乏しい。

したがって、患者や家族を difficult とラベルすることは、一過性の相互作用上の困難を持続的な属性と混同するリスクを負う。代わりに、具体的な行動とその文脈を記述するほうがよい実践である。

コミュニケーションの不成立はこうした不一致の共通分母である。ただし家族レベルの複雑性(重い悲嘆、家族システムの機能不全、精神科的併存症、本当に和解不能な価値観)が寄与することも実際にある。終末期の家族対立に特化した分類は、これら家族内部の駆動因をより詳細に地図化しており、**先行する家族内対立、コミュニケーションの制約、統制の主張が最も強い予測因子**と同定している。

プロセス不全という、よくある・手を打てる駆動因

質的研究では、家族と代理者自身が、個人内の価値の緊張と並んでプロセスの破綻を苦痛の中心として報告している。一貫しない情報、治療決定から排除されている感覚、時間とともに劣化するコミュニケーションなど。

臨床医が「手放せずにいる」と解釈するものを、家族は「患者の価値を尊ぶことと、死の責任を負ったと感じないこととの間の道徳的な葛藤」として経験している。

周縁化された集団の家族にとっては、制度の信頼に値する度合い(trustworthiness)の欠落、人種によってパターン化されたコミュニケーション、言語の障壁が、構造的不公平を関係対立へ転換しうる。

最も研究の進んだ米国では：

- 黒人の介護者は家族面談で受ける情動的支援が少なく、医学的情報も少ない。
- 通訳を介した面談は臨床医の発話が少なく、支持的な発言も少ない。

同じ機序は医療システムを超えて反復する。

- **文化的・言語的に多様な家族の終末期ケア**: コミュニケーションの困難 (利用可能であるにもかかわらず、専門通訳の使用率は5~6%と低い) が、ずれた期待と臨床医の一方的な決定と組み合わせ、反復する対立源になっている。
- **オーストラリア・ビクトリア州の全23公立ICUを対象としたコホート**: 通訳の必要性が正式に同定されていることは調整後死亡率の低下と関連したのに対し、そのフラグなしに英語以外の言語選好があることは死亡率の上昇を伴った。すなわち **言語の違いそのものではなく「言語ニーズを認識していること」がアウトカムを追う。**
- **米国7 ICUのコホート**: 英語能力が限られる患者は快適さ中心のケアへの移行が遅く、身体拘束されることが多かった。
- **ノルウェーの移民家族**: 患者に何を伝えるかを家族側がフィルターしていると述べており、臨床医が開示を統制するという通常の枠組みが反転している。
- **ニュージーランド**: 看護師は、マオリの終末期ケアが whānau (マオリの生活の中心にある拡大家族・親族ネットワーク。西洋の「核家族」より広いことが多い) の包摂にかかっていると述べる。これは、少人数の法的近親者の集まりを前提に組まれた既定のICUプロセスによって妨げられうる。
- **インドのICU**: 臨床医は圧倒的に経済的制約を「医学的助言に反する退院(DAMA)」の主因と同定しており、治療制限は主としてこうした計画外の終末期退院を通じて起きる。結果として患者は緩和ケアなしに、家族は支援なしに残される。

そして反復するパターン: **家族は同じ場面について医師よりも多くの対立を知覚する。**したがってプロセスの不透明さは、あからさな意見の相違が限られていても「対立の経験」を作り出している。

信頼をどう理解し直すか

信頼が既定で、不信は正すべき逸脱、と前提されがちである。しかし多くの患者と家族にとって **不信は誤りではなく、歴史に根拠のある予期された反応である。**

- 集団に基づく医療不信 (group-based medical mistrust) は測定可能で予測的である。
- 重篤な疾患における人種差別の経験、とりわけ「信じてもらえないこと」は不信を深め、コミュニケーションを劣化させる。
- オーストラリアの先住民集中治療でも同じ力学が報告されている。臨床医は、植民地化と過去の否定的な医療体験によって形作られた「人口レベルの信頼の欠損」が先在すると述べ、信頼の確立をケアの土台と名指しする。
- 先住民の患者自身は、人種差別と文化的に安全でないケアを、保健サービスを不信し回避する根拠として述べている。

建設的な一手は、標的を「家族の信頼」から「臨床医と制度の信頼に値する度合い(trustworthiness)」へ移すことである。それは求められると同時に、値するものでなければならない。

著者らは2つの警告を置く。第一に、不信は実在するが、すべての格差の近位原因として確立されたわけではない。不信を調整してもアドバンス・ディレクティブ完成率の格差は縮まらなかった。第二に、不信を固定した属性として扱うと関与放棄のリスクがある。臨床医は、信頼が現在の関係の中で構築可能であることを忘れるべきではない。

Table 3. 臨床医の知覚と家族の経験のギャップ

領域	研究	臨床医の知覚・行動	家族・代理者の経験	枠組みによる解釈
予後の理解	Vick ら	家族は予後を誤解しており、臨床的現実を受け入れる準備がない	臨床医の側も代理者の予後推定を誤って知覚している	見かけ上の価値対立は、部分的には課題レベルの相互誤解を反映する。すべての不一致が理解不足ではない
霊的・文化的価値	Ernecoff ら ／Akeke ら	家族が宗教を持ち出すと臨床医は医学的话题へ引き戻す。黒人家族の霊的懸念との関与はより少ない	代理者はgoals-of-care 面談の16%で宗教的考慮を提起する。宗教は人種を問わず対処の中心	臨床医の関与放棄は、解決可能な課題対立（価値の探索）を関係の傷（切り捨てられた感覚）へ転換しうる
コミュニケーションの十分さ	Anderson ら ／Moss ら	「家族の誤解」あるいは予後の受容困難	代理者は、臨床医やチームをまたいだコミュニケーションの一貫性のなさを懸念として同定する	プロセス不全（断片化したメッセージ）が、課題対立（目標の不一致）に見えるものを生成しうる
代理者の道徳的負担	Schenker ら	家族は「手放すことを拒んでいる」「否認している」	代理者は、患者の価値を尊ぶことと死の責任を感じたくないことの間の、苦痛な個人内の道徳的葛藤を語る	臨床医は代理者の個人内の苦痛を、課題レベルの頑迷さと誤解しうる
対立の有病割合	Schuster ら	医師は相互作用の27.8%で対立を知覚	代理者は同じ相互作用の42.3%で対立を知覚	プロセスの不透明さと情動の放置が潜在的対立を作る
人種の公平性	Ashana ら ／Ray ら	臨床医は「困った」「要求の多い」家族と知覚しうる	黒人の介護者は情動的支援と予後情報をより少なく受け取る。コミュニケーションを組み立て直す負担を語る	体系化されたプロセスの不正と関係の失敗が、家族の特性に帰属されている
言語とアクセス	Thornton ら ／Espinoza Suarez ら	通訳を入れた標準的な面談を実施	通訳を介した面談では臨床医の発話と支持が45%少ない。自律の侵害と満	構造的なコミュニケーション欠損がプロセスの不公平を作る

領域	研究	臨床医の知覚・行動	家族・代理者の経験	枠組みによる解釈
			たされない終末期の願い に結びつく	
パン デミ ック 下	Kentish- Barnes ら	面会制限は感染対策上 の必要	家族は臨床医との関係構 築の困難、物理的分離に よる無力感を語る	制度的プロセス(面会方 針)が関係の損傷を生 成しうる

10. 判断能力を保つ患者 — 見落とされてきた当事者

本レビューは判断能力を欠く患者に重点を置く。多くの重症患者が自らの決定に参加できないからである。しかしその重点は、部分的あるいは変動する判断能力を保つ患者が関わる対立を覆い隠しうる。

- 正式な評価は医師の判断のみによるよりもはるかに少ない数の「判断能力のある患者」を同定するが、**政策文書は少なくともICU患者の4分の1が自らのケアの一部に参加できると示唆している。**
- そして、より浅い・ガイドライン推奨の鎮静への移行が、その集団を拡大している。

意識のある患者が意思疎通できるとき、対立の焦点は「迂回されること」「代弁されること」へ移る。

臨床医は、ICU外でも患者の選好を推し量るのが不得手である。よく引用される2つの研究では、医師は **およそ半数の症例で患者の蘇生を望まない意思に気づいておらず**、話し合った後でさえ同じ患者の選択を確実に予測できなかった。

意識のある患者の意向が代理者やチームと乖離するとき、その不一致は **その是非において検討されるのではなく「判断能力の問題」として再枠組みされるリスクがある。**

著者らはここを鋭く突く。ますます一般的になっているこの種の対立がほとんど研究されていないこと自体が1つの所見かもしれない、と。**浅い鎮静は意識のあるICU患者集団を、その声を尊重するための道具・データ・規範を分野が構築するよりも速く拡大させている。**

11. 駆動因と管理 — 施設間転院という見落とされた入口

十分に研究されていない構造的駆動因として、著者らは施設間転院(inter-hospital transfer)を挙げる。

- 転院患者は集団として重症度が高く、直接入室した患者より転帰が悪い。
- それにもかかわらず **家族はしばしば転院そのものを「生存が達成可能だというシグナル」として読む。**代理者は、転院を手配している医師よりも強く「生存の可能性がより高いこと」を転院の理由として評価する。

- goals-of-care の話し合いは転院前に記録されることが少なく、通常は転院後、しばしば死の間際に行われる。転院が「選好に感受性のある決定」として扱われることは稀である。

したがって転院は、後に対立として現れる「期待と現実のギャップ」の種を蒔いている可能性がある。ただし著者らは **この連鎖が推論的であり、研究の優先課題として残る**と明記している。

家族対立の管理 — まず型を見立てる

状況(何が主たる駆動因か)	確認すること	次の一手
課題対立が優勢	どの決定が具体的に争点か。予後の問い(事実)と価値の問い(選好)が混ざっていないか。不確実性が言語化されているか	具体的な決定を明確化する。不確実性を隠さず明示する。予後の問いと価値の問いを分ける。時間制限つき治療トライアルを検討する
プロセス対立が優勢	家族に会う前にチームの見解が揃っているか。誰が決めるのかを家族に説明したか。面談の記録とフォローアップがあるか	家族に会う前にチームを揃える。決定権の所在を透明に述べる。面談を構造化し、記録されたフォローアップを設定する。ICU滞在全体をカバーする家族コミュニケーションの統合枠組みを使う
関係が断裂している	「あの人たちは患者のことを考えていない」といった不信の言語が出ていないか。当事者が実質的な話に入れない状態か	感情をまず承認する(NURSE)。公式のファシリテーションを手配する。倫理コンサルト、調停、緩和ケア、チャプレンを、争いの性質に合わせて選ぶ
家族対立が主に見える	その下にチームの不一致が潜んでいないか	チーム側の不一致を先に扱う。複雑な家族状況は逆に同僚関係を緊張させうるので、チームのケアも同時に行う

12. ICU内および他チームとの対立

家族対立を駆動するのと同じ課題・プロセス・関係の力学が、臨床チームの内部と境界でも作動する。しかし文献は隣接する構成概念に断片化しており、認識が不十分である (Table 4)。全体として、終末期を含めチーム対立を減らすエビデンスに基づく戦略は不足している。チーム対立は専門職の境界の内側でも越えても生じ、燃え尽き、離職、そして家族に伝えられる内容の一貫性に帰結する。

Table 4. チーム内・チーム間の対立を捉える「隣接文献」

文献群	何を測っているか	対立について何を明らかにするか	何を取り逃がすか
道徳的苦悩	正しい行動が阻まれていると信じるときの、制約された道徳的主体性の情動的負荷	治療の適切性についての未解決の不一致。エピソードをまたぐ道徳的残渣の蓄積(クレッシュエンド効果)	不一致そのものと相手方の視点。課題・プロセス・関係の区別
心理的安全性	対人的リスクを取れる風土の知覚。報復を恐れず懸念を口にする意思	異論が voiced されるか抑圧されるか。低い立場のメンバーを黙らせる階層の役割	具体的な不一致の内容と解決。voiced された懸念が変化につながるか無視されるか
倫理風土	倫理的意思決定の質についての共有された知覚(相互の敬意、開かれた省察、信頼)	学際的な熟議の質。そのユニットが道徳的不一致を建設的に処理しているか	個々の対立エピソードとその軌跡。風土が個々の対立をどう形作るか
協働 (collaboration)	チームワークの質。専門職間のコミュニケーションと調整の評価	コミュニケーションの隙間と決定プロセスの問題。知覚のギャップ(医師は看護師よりはるかに高く協働を評価する)	高い「協働」スコアが、真の解決ではなく対立の回避を覆い隠している場合
不適切な医療の知覚	医療が患者の利益に資さない、または期待される利益に不釣り合いだという臨床医の判断	治療の目標と強度についての課題不一致。異論を唱える臨床医への道徳的負担	プロセスと関係の次元。不一致が voiced されたか抑圧されたか。家族の視点
発言・沈黙 (voice)	安全上の懸念と専門職としての異論を口にする意思。発言の障壁	階層による不一致の抑圧。speaking-up 風土が発言行動を予測する。医療者は安全に関わる懸念を頻繁に差し控える	懸念が voiced された後に何が起きるか。発言が根底の対立を解決するのか増悪させるのか

原表の要点: ICUのチーム対立文献の多くはこれらの隣接構成概念に分散しており、いずれも「conflict」を主要索引語として使っていない。この断片化が「チーム内対立は研究が乏しい」という誤った印象を生む。これらの文献を対立研究の一部として見ると、実質的で概念的に一貫したエビデンス基盤が現れる。

13. 専門職の境界をまたぐ対立

最も記録された形のチーム対立であり、24か国のCONFLICUS研究が示すようにICUで単独最多の対立型である。

ETHICUS-2(36か国)は、終末期決定への看護師の関与が地域間で変異し、**医師と看護師の一致率が約40%から100%まで**ばらつくことを示した。

このギャップには混同されやすい2層がある。

- **構造層**：ベッドサイド看護師は、業務量、重症度、人員不足、あるいはカバーなしに、または申し送り中に組まれた面談日程のせいで、家族面談に参加できないことが多い。ある小児ICUでは **98%の看護師が「面談に出るべきだ」と考えていたが、招かれた者のうち一貫して参加できたのは17%。**成人の多施設サンプルでは **45%が「めったに／全く参加しない」。**
- **文化層**：看護師は必ずしも意見を求められず、同席していても自分の役割が不確かなことがある。

比重は設定によって移る。**資源の豊かな学術施設では、医師が意見を求めないこと(60%)と訓練不足(66%)が、時間圧(10～19%)を上回った。**

いずれにせよ、より弱い看護師-医師協働は、より高い看護師の道徳的苦悩、および不適切な医療の知覚と結びつく。後者は終末期決定への看護師の関与と逆相関する。

この乖離は西洋に限らない。**日本の調査では、ICU看護師は、意向が曖昧な患者に対する緊急手術を支持するために、外科医や集中治療医よりも高い予測生存率を必要とした。**

これと整合して、**症状コントロールが共有され、ユニットが定期的なスタッフミーティングを持つところでは対立が少ない。**これらは個人の発言に頼るのではなく看護師を構造の中に埋め込む「構造的な手当て」である。

異文化間の対立はチーム内にも現れうる。ノルウェーのICU看護師は、自らの職業規範(患者ケアへの全面的責任、理解可能な情報、秩序ある臨床環境)が、家族の文化に根ざしたケア参加への期待と衝突すると述べ、鎮痛の必要性を評価する際に馴染みのない痛みの表現を判断することに苦労した。

APP(ナースプラクティショナー・フィジシャンアシスタント)という新しい境界

ベッドサイドチームは、新しい境界を作る形で変化している。

- **APPは米国成人ICUのおよそ72%に配置され、研修医のいる施設(約52%)より多い。**APPは確立された有効なチームメンバーである。
- その成長は研修医の勤務時間上限にも部分的に駆動されており、「医師・APP・研修医の混成チームがどう役割を交渉するか」についてのエビデンスを追い越した。役割境界の不明確さは対立源として認識されている。

シグナルが最も明確なのは研修医である。

- **外科レジデントの31%が「APPの存在は自分のICU経験を損なう」と回答し、これは「看護師が臨床上の問題をAPPに優先的に回していると感じること」と強く関連した。**
- **救急医学レジデントの3分の2が教育への否定的影響を報告した。**

その根底には「誰が何に責任を持つか」の曖昧さがある。ICUの関係者は研修医に対して不明確または乖離した期待を持ちうるし、分野はAPPが研修医をどこまで代替し、協働し、あるいは教えるのかをなお定義しつつある。これは役割と業務範囲をめぐる新興のプロセス対立であり、この労働力の変化に先行する基礎的なICU対立文献にはほぼ欠けている。

14. 外科医・他科医師との対立

外科医と集中治療医の関係は対立を生みやすい。エスノグラフィと調査研究は、術後の救出(postoperative rescue)への強い外科的志向を記述しており、それは「患者を最後まで見届ける」という個人的なコミットメントに特徴づけられる。

米国ではこれが「**surgical buy-in**」と呼ばれてきた。手術に進むことが、術後の生命維持を受け入れる暗黙の合意として扱われる、という考え方である。

- **全国調査では62%の外科医がそのような非公式の契約を作ることを支持し、多くは術後、特に合併症の後に生命維持を中止することに消極的だった。**
- 複雑な術後経過の情動的負荷は重くなりうる。外科医ではそれは最も多くは罪責感と不安として現れ、臨床的あるいは情動的な回避行動のリスクを伴う。

救出への衝動と、救出が不可能なときに続く情動は、重篤な患者をケアする臨床医の間で広く記述されており、真摯なコミットメントと「患者に対して失敗することへの恐れ」の両方を反映している。

著者らは重要な整理を加える。**不一致は個人の気質よりも役割の緊張(role tension)を反映していると論じるほうが妥当である。**「集中治療医」という役割自体が外科研修を含む複数の経路から入られるからである。**特定の患者への契約に縛られる執刀外科医は、外科研修を受けたうえで集中治療医として診療する医師とは概念的に別物であり、対立文献はこの区別をほとんどしていない。**

外科医と集中治療医の争いは、どちらも擁護可能な2つの主張を反映しうる。

- **外科医の主張:** 術前評価・同意・手術というプロセスを通じて構築された受託者関係(fiduciary relationship)に根ざす、術後の権限。
- **集中治療医の主張:** 集中治療がどのように組織されているかに根ざす権限。

そして **アウトカムデータはどちらにも決着をつけない**。大手術後の生存はしばしば術後合併症の迅速な認識と外科的処置にかかっており、これは外科医を術後ケアに埋め込み続けるべき説得力ある論拠である。

枠組みの言葉に翻訳すると：根底にある課題対立（救いの継続か快適さ中心のケアへの移行か）は通常「正当かつ構造的に生成されたもの」であり、一方で「**誰が決めるか**」というプロセスの曖昧さが境界紛争を生んでいる。

ICUの組織形態は健康システムによる

- 閉鎖型・集中治療医主導のユニットが国際的な規範であり、**米国は閉鎖型ユニットの比率がどの地域よりも低い**。
- 米国で測定された外科医の報告する対立は、外科医を押しつけるリスクのある閉鎖型ユニットで最も高い。一方で外科系ICUの大半は完全閉鎖型ではなく協働型または半開放型である。
- 「**surgical buy-in**」は北米以外で名前のついた構成概念として検証されていない。ただし根底の緊張は他地域にも現れる。家族の見解が助言的である米仏比較では、不十分な事前指示、非有益な治療をめぐる臨床医の道徳的苦悩、無益性についての価値に基づく争い、という同じ中核問題が見出された。

15. ゴールとケアの移行に関わる対立

集中治療と緩和ケアの界面

タイミング、枠組み、コミュニケーションのスタイルをめぐる対立が生じうる。**緩和ケア専門家は集中治療医より課題焦点型の発言が55%少なく、より関係構築的なコミュニケーションへ傾く傾向がある**。

課題対立（いつ、どのように緩和ケアを導入するか）は、2つの要素によって複雑化する。

- ① **プロセス対立**：どちらのコミュニケーション手法が家族との相互作用を統べるのか
- ② **同一性への脅威**：緩和ケアの関与は集中治療医にとって「自分たちのケア、あるいは一次緩和ケアが不十分だったという判定」と読まれうる

これを鎮める2つの構造的な選択：

第一に、一次緩和ケアと専門緩和ケアを区別する。一次緩和ケア＝ICUチーム自身が提供する症状管理と goals-of-care の会話。専門緩和ケア＝複雑または難治例向け。この区別はコンサルトを「チームへの判決」ではなく「日常的な補助」として再枠組みし、専門家だけが正統な手法だと扱われるときに起きる脱技能化 (de-skilling) を防ぐ。

第二に、対立の瞬間ではなく、あらかじめ定めたスクリーニング基準によって専門家を先回りして関与させる。これは関与を標準診療として位置づけ直す。ICU入室のおよそ7件に1件がそうしたトリガーを満たす。観察研

究では、トリガーに基づくコンサルトはICU滞在の短縮と関連し、死亡率には影響しなかった。

ただし優位性は「網羅型」ではなく「標的型」にある。高リスク家族全員に対する、専門家主導の予後焦点型の面談を普遍的に行っても家族の苦痛は減らず、ある試験ではむしろ増えた可能性がある。

入室・トリアージ・退室

同じ「課題 対 プロセス」の緊張が現れる。臨床的適切性をめぐる不一致が、権限をめぐる争いと絡まる。

入室決定の研究は2つの見方を対比する。

- **「重症疾患例外主義(critical illness exceptionalism)」**:ICUを固有の論理を持つ独立した領域として扱う
- **「疾患の連続体(continuum of disease)」**:ICUをより長い軌跡上の1点として見る

そしてこの2つの視点自体が対立源になりうる。

コンセンサス・ガイドラインは、決定責任と対立解決経路を明示した施設方針を求めている。**にもかかわらず3分の1超の病院にそれが無い。**

16. 職位階層をまたぐ対立

上級医(attending, consultant)と下級医の階層も対立源になる。研修医・レジデント・若手臨床医はしばしばベッドサイドに最も継続的に存在するが、決定権限は限られている。質的研究はこれを道徳的苦悩と職業的な距離化(professional detachment)に直接結びつけている。

権威勾配(authority gradient)は研修医の発言を抑圧しうる。障壁として顕著なのは対立への恐れと報復への恐れであり、施設の文脈がそれを悪化させる。

ICUに固有の知見として、Tong らの二次質的解析は、階層が終末期ケアをめぐる対立を形作っていることを見出した。**下位の臨床医は叱責された後に沈黙するようになり、上級医が緩和ケアコンサルトを禁じることもあった。**

ただしこの沈黙は「既定の状態」というより「文脈依存的で脅威特異的」と理解したほうがよい。

- 研修医は馴染みのある安全上の脅威については容易に発言するが、非専門職的な振る舞いについてははるかに発言しない。上級医に非専門職的行動を提起する意思があるのは20%、安全上の脅威については71%。
- 研修医は「発言が安全か」と「うまくいきそうか」の両方を天秤にかけている。

知覚された安全性は、職種よりも「上級臨床医がどう振る舞うか」に強く連動する。

- ICU回診では、指導医の包摂性(inclusiveness)が心理的安全性の支配的な予測因子であり、職種間で有意差がなかった。
- 上位者に異議を唱える能力は、生得的というより訓練可能であるように見える。

発言の勾配は上から下だけではない

上級臨床医も、結果を恐れて率直な判断を差し控えることがある。

- 「failure to fail」文献は、成績不良の研修医について正直な否定的評価を記録することへの指導者の躊躇を記録しており、その理由として不服申し立てと反響が予想されることが挙げられている。教員は専門職性の逸脱を報告することにも同様に消極的である。
- 関連する懸念として、学習者による評価や報告が上級臨床医の正直なフィードバックを抑止するという主張が増えているが、エビデンスは薄く、部分的には誤認を反映している可能性がある。

こうした双方向の制約がICUの対立を実質的に形作っているかどうかは、未解決かつ研究の乏しい問いであり、研究の優先課題である。

17. 原因と帰結

チーム対立が持続する理由を説明する構造的機序が3つ挙げられる。

- ① 階層と制約された発言は、調和ではなく抑圧を反映した「報告される対立の不在」を生みうる。
- ② 決定からの排除が不適切さの知覚を増幅する：症状コントロールの決定が看護師と共有されず医師だけで行われたとき、臨床医が医療を不適切と知覚するオッズは73%高かった。
- ③ 道徳的苦悩は蓄積する：Epstein と Hamric は、未解決の倫理的懸念が道徳的残渣を残し、次のエピソードの閾値を下げる「クレッシェンド効果」を記述した。

道徳的苦悩の主要な駆動因は健康システムを超えて一貫しているように見える。トルコのICU看護師では、最大の源はチーム内のコミュニケーション不良だった。インドの専門家コンセンサスも、家族との対立だけでなく治療チーム内部の対立を解決することを終末期コミュニケーションの明示的な目標として掲げ、その双方を道徳的苦悩と燃え尽きに結びつけている。

倫理風土

DISPROPRICUS研究は、検証された風土質問票を用いて 68 ICU の倫理風土を評価した。

「良好」な風土クラスターに属するICUは、過剰な医療をより良く同定し、「不良」クラスターよりも速く治療制限の決定に到達した。これは「不適切さの知覚」を、手を打てる可能性のある組織変数に結びつける。

道徳的苦悩の概念はその後拡張されており、専用のコンサルテーションサービスが、特にICUスタッフにおいて状況的な道徳的苦悩をわずかに減らす可能性を示している。

帰結

- 同僚との対立は集中治療医の高い燃え尽きと独立に関連する。
- 重症医療の臨床医全般では、高い道徳的苦悩は重度の燃え尽きのオッズをおよそ2～3倍にする。
- 燃え尽きと道徳的苦悩は、離職と離職意向に結びつく。集中治療は米国の学術系医師の中で離職意向率が最も高い部類にあり、関係的・組織的要因が燃え尽きとは独立に離職を予測する。看護師1人あたりの離職コストは米国推計で7.5万ドル。
- 患者レベルでは、系統的レビューが、コミュニケーション不良が患者安全インシデントの24%に寄与し、10%では単独原因だったと報告している。

△ 注意

チーム対立は「人間関係の話」ではなく安全と経営の話 **症状コントロールを医師だけで決めると不適切な医療という知覚のオッズが73%上がる。高い道徳的苦悩は重度の燃え尽きのオッズを2～3倍にする。コミュニケーション不良は患者安全インシデントの24%に寄与し、10%では単独原因。看護師1人あたりの離職コストは7.5万ドル。**ICUの対立を放置することは、安全上の失点と人材流出のコストを毎年支払い続けることに等しい。

18. 介入を対立の型と段階に合わせる

型(課題・プロセス・関係)と段階(発生期 emerging・確立期 established・膠着期 entrenched)をまず同定せずに介入を選ぶと、誤った原因に労力を向けるリスクがある。早期の不一致に適した手法は、対立がいったん確立してしまうと機能しなくなるからである(Table 5)。

エビデンスが支持する順序は、**予防的・設計に基づく介入がまず、次に早期の認識とベッドサイドでの鎮静化、公式支援は膠着した対立のために温存する**である(Table 6)。

Table 5. 対立の型に応じた見立てと最初の一手

型	特徴	ICUでよくある例	収穫の大きい最初の一手	エスカレーションの目安
課題	不一致が事実、データ解、予後、治療選択肢を中心に回る。当事者は対立する臨床的立場を言語化できる	蘇生の選好の話し合い、体外循環補助の適応、抗菌薬の投与期間、輸血閾値、退室可否の評価	争点となっている具体的な決定を明確化する。不確実性を覆い隠さず明示する。予後の問い(事実)と価値の問い(選好)を区別する。選択肢を作る。時間制限つき治療トライアルで二者択一の争いを逐次的な決定に変換する	課題不一致が安定していて情報だけでは解けないとき。真の価値対立であり公式支援が要ることを示唆する
プロセス	「誰がこれを決めたのか」「誰からも聞いていない」。権限、順序、コミュニケーション経路についての混乱	家族が回診から排除される、コンサルト科が主治チームを覆す、病床配分をめぐるトリアージ紛争、術後患者の所有権が不明確	役割と決定権限を明確化する。決定経路を透明に説明する。家族面談を構造化し、事前に擦り合わせ、フォローアップする。すべての職種から構造化された入力を確保する	プロセスの修復だけでは実質的な争いが解けないとき。あるいはプロセス不全が施設の変更を要する構造問題を反映しているとき
関係	個人攻撃、回避、不信の言語(「あの人は気にしていない」)。当事者が実質的に関われない	家族のチームへの不信、チーム間の敵意、診療科間の対抗心、過去の害や制度的不信に根ざし現在の関係に付着した家族・代理者の怒り	感情を直接承認する(NURSE)。防衛的にならずに不信を名指しする。ペースを落とす。立場の下にある利害を探索する。対立がコミュニケーションやエスカレーションにおける構造的不公平を反映していないか検討する	実質的な臨床作業を再開する前に関係の修復が必要なきとき。熟練したファシリテーションや調停が適応となるとき(倫理コンサルトは価値対立が併存する場合に温存)

原表の脚注: エスカレーションの閾値は「段階に合わせる」原則を反映している。早期の課題・プロセス不一致を解決する介入は、対立が関係領域に硬化すると牽引力を失う。多くの対立は複数の型の要素を含むので、目

標は主たる駆動因を同定して対応を合わせることである。

設計と予防

構造化された学際回診は、明示的な多職種入力によって目標の一致(goal concordance)を作ろうとする。ただしエビデンスは不均質で、大規模多施設試験は利益を示さず、メタアナリシスは確実性を「非常に低い」と評価している。

低コストで特定の移行点を狙う2つのレバー：

- **役割の明確化(role clarity)**：誰が何を決めるかを明示することで、プロセス対立が関係対立に転じるのを防ぐ。
- **面談前のチーム擦り合わせ(pre-conference team alignment)**：家族に会う前に不一致を表面化させ、食い違うメッセージを防ぐ。

反復する決定の標準化も同種の働きをする。既定の経路、あらかじめ定めたエスカレーション・デエスカレーションのトリガー、事前に再評価時点を定めた時間制限つき治療トライアル。これらは日常的な選択を前もって決着させ、原則立脚型交渉を係留する客観的基準を供給する。

△ 注意

客観的基準は「事前の合意」がないと逆効果になる **客観的基準の力は、事前の合意に依存する**。基準が行き詰まりを解くのは、当事者がそれを正統だと受け入れているときだけであり、**合意なしに課されたルールは、争点をそのルール自体の上へ移動させてしまう**。院内の「入退室基準」「無益性の方針」を作るときは、**策定プロセスへの当事者の参加そのものが介入の一部**である。

倫理風土の涵養はさらに利益を加えうる。相互の敬意と開かれた学際的省察に特徴づけられる風土は、より低い離職意向と関連しており、これが増悪の閾値を上げる可能性がある。ただし **CODE試験は、医師コーチングだけでは風土を動かすのが難しいことを見出しており、個人ではなくチームレベルの介入を指し示している**。

標的型は網羅型に勝るように見える。

- 長期滞在患者に対する週1回の倫理ファシリテーション付き goals-of-care ラウンドは、小児ICUで重症度調整済み在室日数を減らした。
- 一方、標的を定めない先制的倫理介入は利益を示さなかった。

HELLO試験(60か国370 ICU)は、短いポジティブ・コミュニケーション介入が燃え尽きを減らし、倫理風土と離職意向を改善したが、**報告された職種間対立は減らさなかったことを見出した**。これは、風土に焦点を当てた介入と構造的介入が同一の因果経路の異なる点に作用していることを示唆する。

専門職間教育(interprofessional education) は広く推奨され機序的にも整合するが、不均質性のためアウトカムについて確たる推論はできない。

認識と近位でのデエスカレーション

早期段階では、迅速な認識とベッドサイドでの鎮静化が重要になる。

第一歩は、その不一致が「何をすべきか(課題)」なのか、「どう決めるか(プロセス)」なのか、「損なわれた信頼(関係)」なのかを見極めること。

課題対立とプロセス対立には、**立場ではなく利害に戻る**ことがとりわけ有用である。

ただし利害を引き出すには、しばしば無視される前提条件がある。その筆頭が **情動の承認(emotional acknowledgment)** である。NURSE (Name・Understand・Respect・Support・Explore) のような共感的コミュニケーション枠組みは、価値を掘り起こし会話のペースを整える助けになる。

過去の否定的な医療体験について早めに尋ねることも、受け継がれた不信が「現在の関係の中で生じた対立」と誤読される前にそれを表面化させうる。

予後の不確実性を名指しすることは透明性のシグナルとして増悪を減らしうるが、**再検討の計画なしに開示された不確実性は信頼を損な**いうる。

公式支援 — 争いの性質に合わせる

倫理コンサルテーションは合意の改善と関連するが、在室日数への効果は一貫せず、エビデンスの確実性は非常に低い。

- 最も適するのは、価値・権利・義務の対立といった真に倫理的な問い。
- 分野はコンサルタントの役割を「倫理ファシリテーション」と枠づけている。決定を押しつけるのではなく、当事者が価値を明確化し、正当化可能な選択肢の範囲を同定するのを助ける。
- しかし実際には、コンサルトは道徳的な当惑よりも対立と情動によって起動されることが多い。半数超が対立をはらんだ状況から生じ、約4分の3がスタッフまたはスタッフと家族の不一致を含む。
- したがって 倫理コンサルテーションは、それが設計されていない対立解決の仕事をしばしば求められている。

争いが根本的に関係的である場合、**調停(mediation)** が別個の、利害に基づく経路を提供する。純粹に対人的な対立は臨床倫理ではなく調停や患者相談サービスの領分だという議論が増えている。

とはいえ、適合する場面ではコンサルテーションは有効である。**価値に関わる対立を持ち最終的に死亡したICU患者を対象とした多施設ランダム化試験では、倫理コンサルテーションは非有益なICU日数と人工呼吸日数を減らし、死亡率には影響しなかった。**

教訓は「支援を問題にトリアージすること」。**価値対立には倫理コンサルテーション、関係の膠着には調停またはファシリテーション。**

その他の支援はそれぞれ特定の点で作用する。

- **あらかじめ定めたトリガーで開始する早期緩和ケア**は、ランダム化試験で快適さ中心のケアへの移行を確実に増やす。在室日数への効果は一貫しない。
- **時間制限つき治療トライアル**は、集中治療を期限つきで枠づけ、あらかじめ再評価時点を定める。非有益な治療の減少について予備的なエビデンスがある。
- **対立解決トレーニング**の参加者は12か月時点で持続的な技能移転を報告した。ただしそれ以降の評価はない。
- **潜在的に不適切な治療 (potentially inappropriate treatment) に対する公正プロセス経路 (fair-process pathway)** は、結果が争われたままでも手続き的正統性を与える。現在は関連ガイドラインが推奨している。

Table 6. 主要な対立関連介入のエビデンス要約

介入	主要エビデンス	主要所見	エビデンスの強さ	実装上の留意点
構造化学際回診	前後比較・単施設 (Pronovost 2003) / 系統的レビュー33研究 (Heip 2022) / メタアナリシス30研究・32,000例超 (MacKinnon 2024)	目標理解が10%未満から95%超へ改善し ICU在室日数も短縮 (Pronovost)。系統的レビューは患者中心性と協働に良い傾向を認めるがエビデンスの質は低く不均質 (Heip)。チェックリストのメタアナリシスは死亡率低下を示唆 (RR約0.80、確実性は非常に低い・MacKinnon)	低～中	全職種 of 明示的な入力プロトコルが要る。効果は施設文化とリーダーの行動に依存。構造化スクリプトは看護師の参加と協働プロセスを改善しうる
専門職間教育・協働介入	Cochraneレビュー (Reeves 2013, 2017) / 専門職間シミュレーション訓練のスコوپingleビュー (Bochatay 2025) / IPEC 2023	強く推奨され、共有メンタルモデル・役割の明確化・集団間接触を通じて課題・プロセス・関係の枠組みと整合する。不均質性のため行動や患者アウトカムへの確たる推論はできない。ICUプログラムで対立特異的アウトカムを包括的に測るものはほとんどない	低	一定の条件 (対等な立場・協力・共通目標) が要る。設計が悪いと職業的ステレオタイプを強化しうる。持続的な行動変化は同時並行の構造変化に依存
構造化家族面談	多施設RCT (Lautrette 2007) / 段階的ウェッジクラスターRCT 1,420例 (White 2018) / クラスターRCT 34 ICU・875遺族 (Kentish-Barnes 2022) / RCT 385例 (Kentish-Barnes 2024) / クラスターRCT 16 ICU・885家	終末期支援は遷延性悲嘆を減らす (15% 対 21%, $p=0.035$ ・Kentish-Barnes 2022)。コミュニケーション介入はプロセス指標を一貫して改善するが、代理者の長期心理症状はおおむね減らさない。PARTNERはコミュニケーションの質を改善	プロセスアウトカムと終末期の悲嘆軽減については強い。長期の心理症状軽減については中～弱	終末期に特化したプロトコル (死后面談を含む3ステップモデル) が最も明確な利益を示す。看護師主導の経路はコストを下げコミュニケーションの質を改善しうる。面談前のチーム擦り合わせは決定的だが

介入	主要エビデンス	主要所見	エビデンスの強さ	実装上の留意点
	族 (Naef 2025) / RCT 444代理者 (Butler 2025) / メタアナリシス10試験・3,824代理者 (DeForge 2022)	しICU在室日数を短縮したがHADSスコアは減らさなかった。Four Supports (フィデリティ97%)は全心理アウトカムで無効。メタアナリシスは安定性の不確かな小さい統合効果を示す		研究が乏しい構成要素
先制的倫理ラウンド (PEACEなど)	前後比較・単施設 (Wocial 2017) / 前後比較・3施設6 ICU・1,649例 (Pavlish 2020) / 9年間314件の症例集積 (Meyer-Zehnder 2021) / SCCM診療ガイドライン (Marshall 2025)	倫理ラウンドは単施設研究で在室日数を減らし、道徳的苦悩は看護師でのみ改善 (Wocial)。多施設での再現では支持的サービスのコンサルトは増えたが在室日数の短縮は再現されず (Pavlish)。週1回の倫理カンファは9年間持続可能 (Meyer-Zehnder)。SCCMは集中治療からみれば利益を得ない可能性のある患者への先制的コンサルトを推奨 (確実性は低い)	中 (多施設再現・ガイドラインの支持)	専任の時間とファシリテーターが要る。対立予防を日常業務に埋め込む。網羅的な先制紹介は標的型より効果が低いように見える。看護スタッフに不釣り合いに利益。ECMOなど特定の高侵襲技術にも適応可能
倫理コンサルテーション	多施設RCT 7病院・価値関連の対立を持つ551例 (Schneiderman 2003) / メタアナリシス16研究 (Au 2018) / Cochrane 系統的レビュー適格4研究 (Schildmann 2019) / スコーピングレビュー (Bell 2022) / 後ろ向き・前	Schneiderman RCT: 非生存者では倫理コンサルトがICU日数と人工呼吸日数を減らした。Auメタアナリシス: 治療合意が4倍に増加、ICU在室日数4.65日短縮、非有益な治療の減少。ただしCochraneレビューは全アウトカムで確実性を非常に低いと	低～中 (Cochraneは低確実性、支持的な観察データあり)	トリガー起動型のコンサルトが網羅的紹介より有効。倫理サービスの利用可能性と質の施設間差が大きい。必須方針は持続可能だが導入は不均一。標準化されたアウトカム指標が必要

介入	主要エビデンス	主要所見	エビデンスの強さ	実装上の留意点
	向きコホート1,150例 (Lin 2025)／米国上位50学術病院の調査 (Neal 2020)	評価。倫理コンサルト必須化の方針は倫理的対立の発生減少と関連 (Lin)。米国トップ学術施設の約50%しか必須方針を持たない (Neal)。アウトカム指標は標準化されていない (Bell)		
早期緩和ケア統合	クラスターランダム化クロスオーバー199例 (Ma 2019)／RCT 91例 (Helgeson 2023)／系統的レビュー58研究 (Metaxa 2021)／ESICMガイドライン (Kesecioglu 2024)／SCCMガイドライン (Marshall 2025)／実装レビュー84研究 (Meddick-Dyson 2024)	早期トリガー起動型コンサルトはDNR・DNIへの移行を増やし (50.5% 対 23.4%)、ホスピス転院を増やし、人工呼吸日数と気管切開を減らした。死亡率に差なし (Ma)。第2のRCTでは家族満足度が高い (Helgeson)。ESICMとSCCMは高リスク患者への早期統合を推奨 (低～中確実性)。スクリーニングはコンサルト件数を増やすが下流アウトカムを変えないことがある	強い (腫瘍領域)／中～強い (一般ICU)	トリガー起動型で危機駆動ではなく早期に統合されたときに最も有効。タイミングと枠づけは診療科間対立の源として残る。有効性のエビデンスと実装知識の間に大きな隔たり。エビデンスは主に北米
生命倫理調停 (bioethics mediation)	12か月追跡つき前後比較 (Zweibel 2008)／医療調停の系統的レビュー (Lioupi 2025)／複雑介入の枠組み (Schildmann 2019)	医師への対立解決技能訓練後、12か月時点で持続的な技能移転 (Zweibel)。2008年以降、新たな対照研究はない。系統的レビューは医療紛争のデエスカレーションに調停を支持するがICU特異的ではない	低 (対照アウトカム研究の欠如が続いている)	訓練された調停者が要る。技能は既存の倫理コンサルタントに教える。確立した介入の中では最も弱いエビデンスカテゴリー

介入	主要エビデンス	主要所見	エビデンスの強さ	実装上の留意点
時間制限つき 治療トライアル(TLT)	多施設QI前後比較 209例(Chang 2021)／SCCMガイ ドラインの支持 (Marshall 2025)／ 18の実証研究と15の 倫理分析を統合した ナラティブレビュー (Kruser 2024)／修 正デルファイによる16 の必須要素のコンセン サス定義(Kruser 2024)	TLTを既定のケア計画 として用いると家族面 談が早まり、ICU・入院 在室日数が減り、侵襲 的治療が減った。死亡 率に変化なし。死亡例 でより大きな減少 (Chang)。ICU患者の 8～27%で使用。集中 治療医の65%が馴染 みがあると報告するが 実装は多様で不完全 なことが多く、トライア ル終了時の決定の話 し合いなど鍵となる要 素がしばしば省かれる	低～中(RCTのな い単一の前後比 較QI研究。残りは 観察・質的・調査・ モデリング。完了 したRCTは現時 点でなし)	一般的な家族面 談や公正プロセス 経路とは運用上 区別される。治療 を期限つきで、あ らかじめ定めた再 評価基準とともに 枠づけることが対 立緩和の機序。標 準化された枠組 みが公表されてい るがエビデンスは 主に米国の学術 ICU由来
潜在的に不適 切な治療への 公正プロセス 経路	多学会コンセンサス (Bosslet 2015)／ SCCMガイドライン (Marshall 2025)／ 前向き観察533例 (Hwe 2020)／地域 住民39名のフォーカ スグループ(Neville 2020)	潜在的に不適切な治 療に対する7段階の構 造化エスカレーショ ン。SCCMガイドライ ンはこうした紛争に対 応する施設方針を推 奨(低確実性)。臨床 医が非有益な治療を 認識するだけでは、構 造化されたプロセスな しにその実施は減らな い(Hwe)。地域住民 の69%は「無益な医 療」という言葉を聞い たことがなかった (Neville)	コンセンサスに基 づく。確実性は低 い(SCCMガイド ライン)	手続き的公正の 枠組みを提供す る。実装は施設の インフラと法的文 脈に依存。臨床医 と市民の間のコミ ュニケーション格 差への手当てが 要る。エスカレー ション手段の公平 性への含意は監 督を要する
面談前のチー ム擦り合わせ	専門家推奨。 PARTNERとFICUS で研究された専門職 間コミュニケーション 経路に整合・内包 (Bruce 2015,	食い違うメッセージを 減らし、チーム内の不 一致が家族に到達す るのを防ぐ。単独での 実証評価は存在しな い。多要素介入の中核	低(専門家推奨。 間接的エビデン スのみ)	低コストで実行性 が高い。チーム対 立が家族対立へ 転換する機序その ものに対処する。 単独の実装試験

介入	主要エビデンス	主要所見	エビデンスの強さ	実装上の留意点
	White 2018, Naef 2025)	構成要素として運用されているが、単離した効果は未研究		が一貫して存在しないことは注目すべきエビデンスギャップ
代理者への構造化された心理的支援	パイロットRCT 60代理者 (Lichtenthal 2024) / 代理者介入のメタアナリシス10試験・3,824代理者 (DeForge 2022)	EMPOWER (約2時間の簡易認知行動介入) のパイロットRCTは、3か月時点の悲嘆・PTSD・抑うつへの効果の予備的シグナルを生んだ。確認にはより大規模な試験が必要。コミュニケーションに基づく代理者介入のメタアナリシスは、心理アウトカムに小さく不安定な統合効果しか見出さなかった	低 (パイロットRCT)。概念上の優先度は高い	コミュニケーションのプロセスではなく心理的機序 (体験の回避、対処、情動処理) を標的とする。ICU滞在中に実施可能だがさらなる検証が必要。コミュニケーションの改善と心理的支援は相補的であり冗長ではない
倫理風土の涵養	多施設調査68 ICU・2,992臨床医 (Van den Bulcke 2018, Jensen 2019) / 段階的ウェッジクラスターRCT (Benoit 2024) / 横断研究・米国 (Silverman 2022) / COVID期・オランダ84 ICU (Donkers 2021)	倫理的意思決定風土はICU間で大きくばらつき、離職意向を予測する。医師は看護師より風土を好意的に評価する。倫理風土を対象とした初のRCTであるCODE試験は、構造化コーチングが目標志向のケア決定を改善したことを示したが、倫理風土そのものは改善しなかった	中 (初の介入RCT。強い関連データ)	リーダーの行動と施設の慣行を通じて修正可能。構造化コーチングは実行可能なモデル。心理的安全性の涵養と相補的

略語：CEC＝臨床倫理コンサルテーション、DNI＝挿管しない、DNR＝蘇生しない、ECMO＝体外式膜型人工肺、ESICM＝欧州集中治療医学会、HADS＝Hospital Anxiety and Depression Scale、LOS＝在室・在院日数、PTSD＝心的外傷後ストレス障害、QI＝質改善、RCT＝ランダム化比較試験、RR＝相対リスク、SCCM＝米国集中治療医学会、TLT＝時間制限つき治療トライアル。

19. 近位アウトカムと遠位アウトカム — 臨床的に重要なパターン

これらの支援システムを貫く、臨床的に重要なパターンがある。

近位アウトカム(理解、満足、コミュニケーションの質)は確実に改善する。しかし遺族の遠位アウトカム(長期の不安、抑うつ、心的外傷後ストレス、遷延性悲嘆)はおおむね改善せず、いくつかは無効ないし有害を示した。

情報リーフレット、質問プロンプト、看護師主導の支援、ファシリテーション付き家族面談の試験がこのパターンに当てはまる。**フィデリティ97%で提供された介入も含めて。**

さらに、遺族を支えるつもりで行われたあるランダム化介入は逆の効果を持った。**臨床医による弔意の手紙は、6か月時点の抑うつとPTSD症状を増やした。**

例外は「死のプロセスそのもの」を狙った支援である。

- 積極的な終末期カンファレンス+遺族向け冊子
- 死の前後の遺族の立ち会いに関する3ステップ戦略
- 蘇生中の家族の立ち会いの選択肢
- ICUダイアリー

これらはそれぞれ心的外傷後ストレスまたは悲嘆を減らした。

したがって著者らは明言する。**コミュニケーションと対立の介入は、その近位の利益によって正当化されるべきであり、悲嘆への予防薬として提示されるべきではない。**悲嘆は主として死そのものによって形作られるからである。

なお、代理者自身の対処(coping)を支える介入が、この遠位のギャップに対処し始める可能性を示す初期のエビデンスがある。

20. 実装と今後の方向性

暴力 — 対立管理の終末的な失敗形態か

著者らは暴力を「対立管理の終末的な失敗形態」と見ることができると述べつつ、その結びつけには慎重を要すると強調する。

- ICUの職場暴力は一般的で、スタッフのおよそ31%が身体的暴力を、57%が言語的暴力を報告する。
- しかしそれは圧倒的に患者による加害であり、对人的対立ではなくせん妄と興奮によって駆動される。ある有病割合調査では錯乱が最大の寄与因子であり、面会者や家族によるエピソードは捕捉されなかった。

対立に駆動される家族の攻撃性は別個の経路であり、**エビデンスは薄い**。未解決の対立が暴力へ増悪するという主張は、別々の有病割合文献を並置しているだけで、その連関を検証した研究に基づいていない。したがって **仮説かつ研究の優先課題として扱うのが最善である**。

使える対応は弱く裏づけられ、しかも中立ではない

- **柔軟な面会**はせん妄と家族の不安を減らし、**死亡率や感染を増やさない**。したがって面会制限を懲罰的手段として用いることは正当化しにくい。
- **強制的な対応は公平性のリスクを伴う**。救急外来における身体拘束と警備対応は黒人患者に不均衡に降りかかる。このパターンはICUでは研究が乏しく、米国外では検証されていない。
- したがって、**行動契約、警備介入、面会制限といったエスカレーション手段は、他の高リスク決定と同じ施設の監督を必要とする**。明確な基準なしに用いれば、バイアスを持ち込むリスクがある。

対立と安全上の脅威の区別は維持されなければならない。目標をめぐる通常の見解の相違を「治安の問題」にしてはならない。それは自らの価値を擁護する家族を非正統化する。一方、真の安全上の脅威には固有のプロトコルとデエスカレーション訓練が必要である。

実装は地域の文脈に合わせる

施設の状況	優先すべき投資
燃え尽きが高いユニット	倫理風土の測定と道徳的苦悩の支援から最も利益を得る可能性
苦情が「言うことが一貫しない」に集中するユニット	面談前のチーム擦り合わせを優先する
診療科間の摩擦があるユニット	境界における明示的な役割の明確化が要る
周縁化された集団に医療を提供する場	資源の裏づけられた文化的リエゾンをICUチームに埋め込む。ただし資源不足や単独配置はトークニズムと燃え尽きを招きうる

戦略はまた、判断能力を欠く患者の決定に関する地域の法的アーキテクチャを追うべきである。既定の代理者階層を前提に構築された介入は、最善の利益・利益基盤の法域では適応が必要になる。そこでは正式な責任、したがってプロセス介入の標的が、臨床チームにあるからである。

持続的な改善には、個別で範囲の明確な介入と、保護されたリーダーシップの時間と資源が必要であり、技能訓練だけでは足りない。経済分析は乏しいが、看護師1人あたりの離職コストと「風土と定着の連関」は、対立管理のインフラが定着だけで元を取る可能性を示唆する。

エビデンスの「ドリフト」への注意

統合されたエビデンスは、症例構成、ケア構造、測定、社会規範が公表された知見の下で変化していくことによって漂流(drift)しうる。したがって、いかなる推奨も移送する前に、臨床医は「患者・構造・規範が、そのエビデンスが産出された条件と一致しているか」を問うべきである。

研究の優先課題

著者らが挙げるもの：

- 1 検証された対立特異的な尺度
- 2 対立の解消を副次ではなく主要アウトカムに置いた試験
- 3 研修医を介した対立と「隠れたカリキュラム」の研究
- 4 介入横断的な、公平性で層別化した報告。米国中心に記録されたスティグマ的記録、強制的エスカレーション、不信の力学が、他地域で顕著な階層にも一般化するを含む
- 5 評価は「介入が対立の総量を減らすか」だけでなく、**参加・知覚された敬意・強制的対応が地域で意味のある集団間で異なるかどうか**を問うべきである。総量の改善は、不変あるいは拡大した不公平を覆い隠しうる。
- 6 **集団思考(groupthink)と早すぎる合意の文献は驚くほど薄い**。階層とチームの調和への圧力が集中治療に内在する主要な駆動因であるにもかかわらず。これは方法論的困難、あるいは「現在のチーム構造が依存している力学」を研究することへの躊躇を反映しているのかもしれない。
- 7 **対立後の回復(post-conflict restoration)はICUの質文献にほぼ存在しない**。道徳的に困難な対立の後のチーム・デブリーフィング、道徳的苦悩の明示的な処理、家族へのサービス・リカバリーは、それぞれクレッシェンド効果を断ち切りうる。責任追及ではなく学習に向けられた回復的(restorative)な文化の中で。

21. 結論(著者らの言葉で)

家族対立とチーム対立はICUの別々の問題ではなく、絡み合った1つの問題である。それは、不確実性・高い道徳的賭け金・分散した権限のもとで、ユニットが意見の相違をどう扱うかに由来する。

道徳的苦悩、心理的安全性、倫理風土、協働の各文献は、単独では別物に見える。しかしそれらは異なるレンズを通して同じものを測っている。すなわち「**制度と個人が、競合する価値と還元不能な不確実性をどう処理するか**」である。これらを統合すると、ICU対立の遍在性と、同時にその修正可能性の両方が見えてくる。

対立が生じたとき、目標は意見の相違を抑圧することではない。その型を認識し、課題領域とプロセス領域から関係領域へ移動する前に介入することである。関係領域では対立は膠着し、破壊的になる。

個人のコミュニケーション技術は、構造的な失敗を確実に埋め合わせることはできない。構造化された回診、役割の明確化、面談前の擦り合わせ、倫理風土の涵養、そして公平なエスカレーションに注意を払ったシステム設計こそが、より耐久性のある投資である。これらの手立ては、信頼が依存する条件を回復する。すなわち承認、敬意、統合性、そしてアカウンタビリティである。

集中治療における意見の相違は不可避である。破壊的な対立はそうではない。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

1. 枠組みそのものがICUで検証されていない 著者らは冒頭で「課題・プロセス・関係の枠組みは集中治療で特に検証されたわけではない」と明記している。組織心理学の職場チーム研究と、医療チーム対立の統合レビュー1本が支柱である。著者らはこれを「整理のための発見的枠組み(organizing heuristic)」と呼び、3つの検証可能な予測を提示することで誠実に扱っているが、**JCではまず「これは仮説であって知見ではない」ことを確認すべきである**。とりわけ「対立は課題→プロセス→関係へ移動する」という中心的主張には、ICUでの縦断的な検証がない。著者ら自身が図の凡例で「固定した順序ではない」「一部の患者・家族では不信が先在し、対立は関係領域から入ってくる」と留保している。

2. ナラティブレビューであることの帰結 系統的レビューではない。文献の選択は著者らの判断であり、「Strength of Evidence」欄も「形式化・プロトコル化された格付けではなく、著者らの質的判断」と明記されている。すなわち Table 6 の「強い／中／低」は GRADE ではない。著者らは自らの立場を「間主観的(intersubjective)で、比較可能な測定値の集計に還元できない」と明言している。**この自己申告は誠実だが、同時に「読者が結論の頑健性を独立に評価できない」ことを意味する。**

3. Table 2 の数値は分母が異なる2つのコホートの混成である 著者ら自身が最も長い脚注をここに割いている。Studdert らの割合は相互排他的な当事者カテゴリーへの分割で合計100%(チーム-家族57%、チーム内31%、家族内12%)。CONFLICUS の割合は「対立を報告した回答者のうち各当事者と対立した者の割合」で重複があり合計100%にならない(チーム-家族17%、チーム-患者17%)。**同じ表の同じ行に「57%」と「17%」が並んでいるが、これらは比較できない**。JCでこの表を引用するときは必ずこの注記を付けるべきである。さらに、情動反応や不信のカテゴリーは「対立そのもの」ではなく「対立への既存の脆弱性」を反映しうる、と著者らも認めている。

4. 「チーム-家族対立の約半分はプロセス問題」という中心的主張の出典の細さ 本文は「コミュニケーション不良と生命維持治療をめぐる不一致にほぼ半々に分かれる」と述べ、Table 2 ではコミュニケーション不良44%、生命維持治療の選好の衝突44%となっている。これは主として Studdert ら(2003年、長期滞在ICU患者)の単一コホートに由来する。**20年以上前の、特定の患者集団(prolonged stay)のデータが、本レビューの最も引用されやすい主張を支えている**。著者ら自身が最終節で「エビデンスのドリフト」を警告していることと合わせて読むべきである。

5. 「困った家族」を脱構築する議論の、実証的な射程 このレビューで最も説得的なパートだが、支えているエビデンスの質は一様ではない。難しさが臨床医の燃え尽き・職務不満足と相関することは家庭医療・地域精神保健の研究に由来し、ICUのものではない。黒人患者にネガティブな記述語が約2.5倍という数字は米国の電子カルテ研究であり、著者ら自身「その駆動因は研究が乏しい」と書いている。**主張の方向は妥当だが、日本のICUにそのまま移送できるかは別問題である。**著者らは公平性の顕著な軸が設定によって異なると明記しており、日本での該当軸(言語、国籍、経済状況、家族構造など)は自前で同定する必要がある。

6. 介入エビデンスの弱さが、結論の力強さと釣り合っていない 著者らの結論は「構造的投資こそ耐久性がある」だが、Table 6 を素直に読むと、その推奨の柱は軒並み弱い。

- 構造化学際回診: 大規模多施設試験は無効。メタアナリシスの確実性は非常に低い(RR約0.80)
- 面談前のチーム擦り合わせ: 単独での実証評価が存在しない(低・専門家推奨・間接エビデンスのみ)
- 専門職間教育: 低
- 生命倫理調停: 低(2008年以降、新たな対照研究なし)
- 倫理コンサルテーション: Cochraneは全アウトカムで確実性を非常に低いと評価
- 公正プロセス経路: コンセンサスに基づき、確実性は低い

つまり「最も推されている介入(擦り合わせ)が、最もエビデンスの薄い介入でもある」という構図がある。著者らはこれを隠していない(「単独の実装試験が一貫して存在しないことは注目すべきエビデンスギャップ」と明記)が、抄録と結論の力強さは Table 6 の実態より強く響く。

7. HELLO試験の結果は枠組みにとって不都合ではないか 60か国370 ICUのHELLO試験は、燃え尽き・倫理風土・離職意向を改善したが「報告された職種間対立は減らさなかった」。著者らはこれを「風土介入と構造介入は同じ因果経路の異なる点に作用する」と解釈する。しかしこれは事後的な救済的解釈とも読める。代替解釈として「対立の自己報告が介入に感受性のない指標である」「風土の改善は対立の量ではなく質を変える」なども成り立つ。検証された対立特異的尺度が存在しないという著者ら自身の指摘が、ここで効いてくる。

8. 近位・遠位の非対称に対する説明が十分か 「コミュニケーション介入は近位を改善するが遠位(遺族の心理)を改善しない」というパターンは頑健で重要である。著者らはこれを「悲嘆は主に死そのものによって形作られる」と説明する。ただし別の説明も可能である。すなわち、介入の用量が不十分、アウトカム測定のタイミングが不適切、あるいは代理者の非対称という構造的問題(知識・権限・枠組みの欠如)そのものが介入では動かない、という説明。著者ら自身が「これらの非対称は構造的な特徴であり、それが集中的なコミュニケーション介入が家族の心理アウトカムを確実に改善してこなかった理由の説明を助ける」と本文で述べているので、論文内に2つの説明が併存しており、どちらが主かは決着していない。

9. 弔意の手紙が害を与えたという知見の扱い ランダム化試験で臨床医の弔意の手紙が6か月時点の抑うつとPTSD症状を「増やした」という結果は、本レビューで最も行動を変えうる単一の知見だが、1段落で触れられ

るにとどまる。「善意の家族支援が測定して初めて害と分かった」という、この分野で最も重要な教訓の1つであり、JCではここを深掘りする価値がある。

10. 日本への外挿における具体的なずれ

- 法域モデル：日本は米国型の制定法上の代理者階層でも、英国型の最善の利益モデルでもない。本論文の「プロセス介入の標的は法的アーキテクチャに従う」という指摘は、日本では「そもそも標的がはっきりしない」ことを意味する。
- 終末期実践の地域差：本論文の欧州北部47%・中部34%・南部18%、インド7%という数字の中で、日本がどこに位置するかは本論文からは分からない。ETHICUS-2 と東アジア比較研究が引用されているのみ。
- 引用された唯一の日本のデータは「ICU看護師は意向が曖昧な患者への緊急手術を支持するのに、外科医や集中治療医より高い予測生存率を必要とする」という調査(Yamamoto 2025)である。**職種間の閾値のずれが日本でも存在することの示唆であり、当院で再現しうるかは検証に値する。**
- APP(ナースプラクティショナー・フィジシャンアシスタント)の議論は米国の労働力構成(成人ICUの72%)が前提。日本の特定行為研修修了看護師の位置づけは異なるが、「役割境界の曖昧さが新しいプロセス対立を生む」という構造は移送可能である。

11. 判断能力を保つ患者の節は、レビューの中で唯一「空白の指摘」で終わっている 著者らは「少なくともICU患者の4分の1が参加可能」「浅い鎮静がその集団を拡大している」「にもかかわらず研究が乏しいこと自体が所見」と書く。Table 2 のチーム-患者行には「研究が乏しい」「エビデンスの空白」がそのまま入っている。**これは本レビューの最も価値のある問題提起であると同時に、枠組みが実質的な指針を出せていない箇所でもある。**

12. 暴力と対立の結びつきについて、著者らは自ら反証している「未解決の対立は暴力に増悪する」という直感的な物語を、著者らは明示的に退けている。ICUの職場暴力(身体的31%・言語的57%)は圧倒的に患者による加害でせん妄と興奮が駆動因であり、ある有病割合調査では面会者・家族のエピソードは捕捉すらされていなかった。**この誠実さは評価すべきで、逆に「対立管理を暴力予防として売り込む」院内の議論があれば、その根拠は本論文にはないと言える。**

主要な引用文献

内容	著者・雑誌・年
ICU対立の基礎データ(24か国323 ICU、71.6%が直前1週間に対立)	Azoulay E, Timsit JF, Sprung CL, et al. CONFLICUS study. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180(9):853–60.
課題・関係対立の原典(3類型の元になった実証研究)	Jehn KA. A multimethod examination of the benefits and detriments of intragroup conflict. Adm Sci Q. 1995;40(2):256–82.
集団内対立のメタアナリシス(枠組みの主要な支柱)	de Wit FR, Greer LL, Jehn KA. The paradox of intragroup conflict: a meta-analysis. J Appl Psychol. 2012;97(2):360–90.
課題対立 対 関係対立とチーム成績のメタアナリシス	De Dreu CKW, Weingart LR. J Appl Psychol. 2003;88(4):741–9.
医療チーム対立の統合レビュー(枠組みの医療への適用)	Almost J, Wolff AC, Stewart-Pyne A, et al. J Adv Nurs. 2016;72(7):1490–505.
長期滞在ICU患者の対立の型・源・予測因子(Table 2 の主要出典)	Studdert DM, Mello MM, Burns JP, et al. Intensive Care Med. 2003;29(9):1489–97.
対立は臨床医の視点だけでは足りない(医師27.8% 対 代理者42.3%)	Schuster RA, Hong SY, Arnold RM, White DB. Crit Care Med. 2014;42(2):328–35.
医師と代理者の予後の不一致(53%)	White DB, Ernecoff N, Buddadhumaruk P, et al. JAMA. 2016;315(19):2086–94.
治療制限をめぐる対立の「鑑別診断」	Goold SD, Williams B, Arnold RM. JAMA. 2000;283(7):909–14.
「困った家族」をICUでどう理解し対応するか	Metaxa V, Nacul FE, Morris AC. Crit Care. 2025;29(1):22.
「困った患者」概念の古典	Groves JE. Taking care of the hateful patient. N Engl J Med. 1978;298(16):883–7.
「困った患者」の道徳的再構成	Fiester A. Am J Bioeth. 2012;12(5):2–7.

内容	著者・雑誌・年
診療録のネガティブな記述語と人種バイアス(約2.5倍)	Sun M, Oliwa T, Peek ME, Tung EL. Health Aff (Millwood). 2022;41(2):203–11.
代理者の個人内の道徳的葛藤(「彼を死なせようと言う役はやりたくない」)	Schenker Y, Crowley-Matoka M, Dohan D, et al. J Gen Intern Med. 2012;27(12):1657–65.
代理者の長期の決定後悔(6か月で5人に1人が中等度以上)	Andersen SK, Butler RA, Chang CH, et al. Crit Care. 2023;27(1):61.
共同意思決定行動と代理者の医師への信頼	Lincoln TE, Buddadhumaruk P, Arnold RM, et al. Chest. 2023;163(5):1214–24.
goals-of-care 面談での宗教的・霊的発言への臨床医の応答(16%で提起)	Ernecoff NC, Curlin FA, Buddadhumaruk P, White DB. JAMA Intern Med. 2015;175(10):1662–9.
重症医療における人種と共同意思決定の差	Ashana DC, Welsh W, Preiss D, et al. JAMA Intern Med. 2024;184(4):424–32.
通訳を介した家族面談では情報と支援が少ない	Thornton JD, Pham K, Engelberg RA, et al. Crit Care Med. 2009;37(1):89–95.
言語の障壁と通訳がICUアウトカムに与える影響(ビクトリア州23 ICU)	Duronjic A, Ku D, Chavan S, et al. J Crit Care. 2023;73:154182.
欧州の終末期実践の南北勾配(原典)	Sprung CL, Cohen SL, Sjobqvist P, et al. Ethicus Study. JAMA. 2003;290(6):790–7.
世界のICU終末期実践の変異(ETHICUS-2)	Avidan A, Sprung CL, Schefold JC, et al. Lancet Respir Med. 2021;9(10):1101–10.
終末期実践への看護師の関与の国際変異(ETHICUS-2、一致率40～100%)	Benbenishty J, Ganz FD, Lautrette A, et al. Int J Nurs Stud. 2024;155:104764.
不適切な医療の知覚(医師単独決定でオッズ73%高い)	Piers RD, Azoulay E, Ricou B, et al. JAMA. 2011;306(24):2694–703.
倫理風土と過剰治療の同定(DISPROPRICUS、68 ICU)	Benoit DD, Jensen HI, Malmgren J, et al. Intensive Care Med. 2018;44(7):1039–49.
倫理的意識決定風土の測定ツールの開発と検証	Van den Bulcke B, Piers R, Jensen HI, et al. BMJ Qual Saf. 2018;27(10):781–9.

内容	著者・雑誌・年
倫理風土と離職意向(68 ICU)	Van den Bulcke B, Metaxa V, Reyners AK, et al. Intensive Care Med. 2020;46(1):46–56.
CODE試験(医師コーチングは倫理風土を動かさなかった)	Benoit DD, De Pauw A, Jacobs C, et al. Intensive Care Med. 2024;50(10):1635–46.
HELLO試験(370 ICU・60か国、燃え尽きは減ったが職種間対立は減らず)	Azoulay É, Myatra SN, Heras La Calle G, et al. Intensive Care Med. 2025;51(11):2031–41.
道徳的苦悩・道徳的残渣・クレッシェンド効果	Epstein EG, Hamric AB. J Clin Ethics. 2009;20(4):330–42.
ICUチームの道徳的苦悩と「パ・ド・ドウ」	Bruce CR, Miller SM, Zimmerman JL. Crit Care Med. 2015;43(4):823–31.
緩和・終末期ケアにおける臨床医間の対立(階層・沈黙)	Tong W, Murali KP, Fonseca LD, et al. J Palliat Med. 2022;25(10):1501–9.
緩和ケア専門家と集中治療医の対立管理スタイルの差(課題焦点発言55%少)	Chiarchiaro J, White DB, Ernecoff NC, et al. Crit Care Med. 2016;44(5):934–42.
心理的安全性の原典	Edmondson A. Adm Sci Q. 1999;44(2):350–83.
外科医が報告する集中治療医との術後ゴールをめぐる対立	Paul Olson TJ, Brasel KJ, Redmann AJ, et al. JAMA Surg. 2013;148(1):29–35.
倫理コンサルテーションのRCT(非有益なICU日数・人工呼吸日数を減らす)	Schneiderman LJ, Gilmer T, Teetzel HD, et al. JAMA. 2003;290(9):1166–72.
潜在的に不適切な治療への公正プロセス(多学会ポリシーステートメント)	Bosslet GT, Pope TM, Rubenfeld GD, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015;191(11):1318–30.
終末期の3ステップ戦略+遺族向け冊子(NEJM原著)	Lautrette A, Darmon M, Megarbane B, et al. N Engl J Med. 2007;356(5):469–78.
弔意の手紙は6か月時点の抑うつ・PTSD症状を増やした(RCT)	Kentish-Barnes N, Chevret S, Champigneulle B, et al. Intensive Care Med. 2017;43(4):473–84.
看護師ファシリテーターのRCT(家族の心理アウトカムを改善せず)	Kentish-Barnes N, Azoulay E, Reignier J, et al. Intensive Care Med. 2024;50(5):712–24.

内容	著者・雑誌・年
交渉学の古典(利害 対 立場)	Fisher R, Ury W, Patton B. Getting to Yes. 3rd rev. edn. Penguin Books; 2011.
ICUの職場暴力の系統的レビュー・メタアナリシス(身体31%・言語57%)	Berger S, Grzonka P, Frei AI, et al. Crit Care. 2024;28(1):61.
意向が曖昧な重症患者への治療決定における職種差(日本)	Yamamoto K. Health Sci Rep. 2025;8(3):e70564.
インドの終末期・緩和ケアに関する専門家コンセンサス	Mani RK, Bhatnagar S, Butola S, et al. Indian J Crit Care Med. 2024;28(3):200-50.
公正文化(just culture)と回復的正義	Dekker SWA, Breakey H. Saf Sci. 2016;85:187-93.

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICUの対立は「何をすべきか(課題)」→「誰がどう決めたか(プロセス)」→「信頼と敬意が壊れたか(関係)」と移動し、**関係領域に入ると解決は格段に難しくなる**。したがって「**困った家族**」というラベルを貼る前に、その手前でどのプロセスが壊れていたかを見にいくのが第一手である。

臨床で明日から変わること:

- **家族に会う前に、チーム内で見解を揃える**(3分でよい。未解決のチーム不一致は「言うことが違う」として家族に届く。ただし単独評価のエビデンスは存在しない、という前提つきで)
- **「困った」ではなく「行動と文脈」をカルテに書く**(スティグマ的記述語は他の臨床医に伝播し、米国では黒人患者に約2.5倍付く)
- **術後患者・入退室・転院の「決定権の所在」を1枚に明文化する**(診療科間対立の本質は課題ではなくプロセス。3分の1超の病院にこの方針がない)
- **緩和ケアは揉めてから呼ばず、トリガー基準で先に呼ぶ**(ICU入室の7件に1件が該当。網羅型の予後面談は家族の苦痛を減らさず、増やした試験もある)
- **看護師が家族面談に出られるよう、業務設計の側を直す**(「出るべき」と考える看護師98%に対し、継続的に出席できたのは17%。学術施設では時間圧より「医師が聞かない60%」「訓練不足66%」が上回る)
- **浅い鎮静で増えている「話せる患者」本人に、先に聞く**(少なくとも4分の1が参加可能。本人の異論が「判断能力の問題」に読み替えられるリスクがある)

売り込み方を間違えないこと:**コミュニケーション介入は理解・満足・会話の質という近位アウトカムを改善するが、遺族の長期の不安・抑うつ・PTSD・遷延性悲嘆はおおむね改善しない**。弔意の手紙のRCTでは6か月時点の抑うつとPTSD症状がむしろ増えた。**家族支援は「遺族の心理予防」ではなく、近位アウトカムとスタッフの燃え尽き・離職の改善で正当化する**。

そして著者らの一文:**集中治療における意見の相違は不可避だが、破壊的な対立は不可避ではない**。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。